



PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE VIH / SIDA / ITS

Guía de Atención Integral de las Infecciones de Transmisión Sexual

2010

La salud ya es de todos!



Ministerio de Salud Pública



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La salud ya es de todos!



Ministerio de Salud Pública



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR



PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE VIH / SIDA / ITS



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud
Representación Ecuador

GUÍA DE
ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS
INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN
SEXUAL
2010



AUTORIDADES

Dr. David Chiriboga
Ministro de Salud Pública
Dra. Ximena Abarca
Subsecretaria General de Salud
Dra. Fátima Franco
Subsecretaria Regional Costa, Insular y Galápagos
Dra. Nidia Rodríguez
Subsecretaria de Extensión de Protección Social
Dra. Carmen Laspina
Directora General de Salud
Dr. Juan Martín Moreira
Director de Control y Mejoramiento de la Salud Pública
Dr. Luis Morales
Jefe Nacional del Programa de Control y Prevención del VIH/SIDA - ITS

Diseño, Ilustración y Diagramación
Mantis Comunicación
mantis@mantis.com.ec
Corrección de Textos
Paulina Rodríguez
Imprenta
xxxxxxx



Autores

Dr. Rodrigo Tobar
Dra. Susana Tamayo Tello
Dra. Mónica Cárdenas Velasco
Dr. Jorge Centeno Coronel
Dr. Telmo Fernández Cadenas
Dr. Marcos Loor Goya
Dr. Luis Morales
Dr. Walter Moya
Dr. Manuel Ordóñez Murillo
Dr. Julio Palomeque Matovelle
Dra. Fanny Pérez Naranjo
Dra. Mónica Pesántez Pesántez
Dr. Walter Remache
Dr. Gonzalo Rivadeneira
Dr. Galo Sánchez
Lcdo. Efraín Soria Alba
Dr. Juan Vaca Oña
Dr. Luis Alfredo Zambrano



REVISIÓN 12,13 y 14 de OCTUBRE 2009

Dr. Iván Haro, Departamento de Epidemiología de Manabí

Dr. Víctor Larreátegui, Servicio de Atención Integral de Salud Sexual (SAISS) N° 1 de Guayas

Dr. Patricio Bolaños, Departamento Metropolitano de Salud del Municipio de Quito

Obst. Alida Silva, Hospital Ginecológico Isidro Ayora de Quito

Obst. Mercedes Díaz, SAISS N° 1 de Guayas

Obst. Martha Leyton, SAISS N° 1 de Guayas

Dra. Zully Andrade, Área de Salud N° 5 de Esmeraldas

REVISIÓN 28,29 y 30 de OCTUBRE 2009

Dra. Gabriela Delgado, Dr. Fidel Mendoza, Área de Salud N° 1 de Manabí

Dra. Amanda Sánchez, Área de Salud N° 4 de Manabí

Dra. Maitté Arteaga, Área de Salud N° 3 de Manabí

Obst. Ivis Román, Área de Salud N° 2 de Manabí

Dra. Laura Dávalos, Departamento de Epidemiología de Pichincha

Dra. Abigail Portero, Área de Salud N° 4 de Pichincha

Obst. Sandra Capelo, SAISS N° 5 de Pichincha

Dra. Amparito Córdoba, Área de Salud N° 21 de Pichincha

Dr. Luis Mena, Departamento de Epidemiología de Guayas

Dr. Jorge Banegas, Área de Salud N° 5 de Guayas

Obst. Mirella Soledispa, SAISS N° 1 de Guayas

Dr. Robinson Jaramillo, Centro N° 1 Mabel Estupiñán

Lcda. Miriam Rivera, Departamento de Epidemiología de El Oro

Lcda. Sara Saraguro, Hospital Teófilo Dávila

Lcda. Percy Quiñónez, Departamento de Epidemiología de Esmeraldas

Dra. Norma Calderón, Área de Salud N° 1 de Esmeraldas

AGRADECIMIENTO

- A las instituciones participantes por su contribución en la elaboración del presente manual

Dirección Provincial de El Oro

Dirección Provincial de Guayas

Dirección Provincial de Manabí

Dirección Provincial de Esmeraldas

Dirección Provincial de Pichincha

Dirección Provincial de Orellana

Hospital Enrique Maridueña

Hospital San Vicente de Paúl

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora

SAISS 1, 3, 5 de Pichincha

SAISS 17 de Santo Domingo de los Tsáchilas

SAISS 1, 2 de Guayas

SAISS 2 de Ambato

Corporación Kimirina

Departamento de Salud de Altura del Ilustre Municipio de Quito

Fundación Equidad

Cemoplaf

- A los participantes en los talleres realizados en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Galápagos y Azuay

- A la revisión de la Organización Panamericana de la Salud



CONTENIDO

Introducción	8
CAPÍTULO I.....	9
Objetivos	
CAPÍTULO II.....	10
Definiciones	
CAPÍTULO III.....	12
Las infecciones de transmisión sexual	
CAPÍTULO IV.....	18
Tipos de manejo de las ITS	
CAPÍTULO V	20
Manejo de las ITS en Ecuador	
CAPÍTULO VI	24
Diagnóstico y tratamiento de ITS con manejo sindrómico	

CAPÍTULO VII.....	44
Abordaje etiológico de las ITS	
CAPÍTULO VIII.....	53
Sífilis	
CAPÍTULO IX.....	59
Consejería y educación	
CAPÍTULO X.....	65
Otras ITS frecuentes	
CAPÍTULO XI.....	66
Atlas de ITS	
ANEXO 1.....	78
Clasificación de las ITS	
ANEXO 2.....	79
Flujograma de atención de las ITS	
Bibliografía.....	80

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grave problema de salud pública. Se estima una incidencia anual de alrededor de 38 millones de ITS tratables en la región de América Latina. Algunos estudios indican que cada año aproximadamente el 20% de los adultos jóvenes y adolescentes sexualmente activos contraen una infección de transmisión sexual. Estas cifras respaldan la necesidad de fortalecer la capacidad de los servicios de salud en todos los niveles para evaluar y atender de forma integral a las personas con ITS, así como abordar los comportamientos de riesgo asociados que perpetúan la transmisión.

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, considera prioritario mejorar e incorporar en los servicios del sector salud el manejo integral de las ITS, en todos los niveles de atención, para que, mediante la utilización adecuada y oportuna de los recursos diagnósticos de los que se dispone, se apliquen estrategias de prevención y tratamiento que han demostrado ser efectivas.

Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades locales, en el año 2006, se implementó en Ecuador el manejo sindrómico de las ITS, que representa una alternativa de abordaje eficiente de este problema en la atención primaria de salud (APS). Dicho enfoque se basa en:

- La identificación de los principales grupos de síntomas y signos (síndromes), comúnmente asociados a ciertas infecciones.
- El tratamiento con una combinación de fármacos efectivos para las infecciones que con mayor frecuencia son responsables del síndrome correspondiente.
- El empleo de flujogramas que estandarizan las acciones a desarrollar y en los que incluyen las 4 C:
 - Consejería para mejorar la percepción del riesgo.
 - Cumplir el tratamiento por medio de toma supervisada.
 - Contactos atendidos para romper la cadena de transmisión de ITS.
 - Condones entregados en cada atención de ITS junto con la demostración del uso correcto.

Esta guía es una adaptación de los manuales de manejo sindrómico de las ITS que ha presentado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que han sido aceptados como base de las normas de atención en los países de la región de América Latina. La revisión y validación incluye la incorporación del uso de las 3 R, que hace referencia a las siguientes acciones prioritarias definidas por el país:

- Recordar la oferta de las pruebas de VIH y VDRL.
- Registrar y reportar las atenciones realizadas.
- Retorno del usuario y usuaria para control.



CAPÍTULO I

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Brindar a los proveedores de salud conocimientos actualizados sobre el manejo de las ITS, basados en evidencia científica, para mejorar la calidad de atención integral a los usuarios y disminuir el impacto de las ITS en la población, a través de la implementación y aplicación estandarizada de las normas de atención en el Sistema Nacional de Salud.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Incorporar los enfoques de derechos humanos, género, diversidad sexual, intercultural y generacional en la atención.
- Estandarizar criterios técnico-operativos para el diagnóstico y tratamiento de las ITS en los diferentes niveles de la atención.
- Incorporar acciones de prevención y promoción como consejería, cumplimiento de tratamientos, entrega y demostración del uso correcto, constante y consistente del condón, atención a contactos.
- Fortalecer el trabajo del equipo multidisciplinario para lograr estándares de calidad.
- Mejorar la notificación, monitoreo y evaluación de las ITS que se atienden en los diferentes niveles de atención, mediante el registro y reporte de cada atención de ITS.

Fuente: Adaptado de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Atkins, D., Best, D., Briss, PA., Eccles, M., Falck-Ytter, Y., Flottorp, S., *et al.*



CAPÍTULO II

DEFINICIONES

2.1. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Comprende un conjunto de infecciones, de variada etiología, que se manifiestan de diferente forma en el organismo y de manera específica en órganos internos y externos del aparato reproductor femenino y masculino, que se adquieren predominantemente por contacto sexual con una persona infectada, sin ser este el único mecanismo de transmisión.

2.2. SEXUALIDAD HUMANA

No existe un concepto único de sexualidad, lo importante es precisar que su significado abarca muchos aspectos que no existen separadamente; hablar de sexualidad de manera integral¹ significa abordar sus principales componentes, como sentimientos, sensaciones, pensamientos, actitudes y comportamientos de seres humanos que se relacionan entre sí, a partir de relaciones de género socialmente construidas, de acuerdo a los significados y valores culturales de una sociedad en un momento histórico determinado.

La OMS considera que: "La salud sexual es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y responsables de capacidades sexuales que conducen al bienestar personal y social, enriqueciendo la vida individual y social. No es simplemente la ausencia de disfunciones, enfermedad y/o malestar. Para poder conseguir y mantener la salud sexual es necesario que se reconozcan y defiendan los derechos sexuales de todas las personas".²

2.3. PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO

Para mejorar la calidad de servicios que ofertan, los servicios de salud deben cumplir con algunas características:

1. OPS/OMS y Asociación Mundial de Sexología, 2000.
2. Ibídem.



- Incorporación en los servicios de intervenciones orientadas a fomentar el conocimiento y autocuidado de la salud.
- Integración de la estrategia de prevención de ITS - VIH/Sida en servicios de atención primaria y secundaria como consultas prenatales, servicios diferenciados para adolescentes, planificación familiar, consultas de especialidad de urología, dermatología y ginecología, entre otros.
- Sensibilización y capacitación del personal de salud.
- Disponibilidad de insumos para el diagnóstico y tratamiento de ITS (pruebas de VIH, VDRL o RPR y condones, entre otros).

Estos servicios deben buscar estrategias para respetar los siguientes principios:

- **Privacidad:** Garantizar al usuario un ambiente seguro antes, durante y después de la atención.
- **Confidencialidad:** Proteger los datos de todos los individuos, durante el almacenamiento y/o transferencia de la información, evitando el uso no autorizado de la información por terceros.
- **Accesibilidad:** Garantizar el acceso a la atención integral al usuario.

2.4. ENFOQUES

La presente guía utilizará como ejes transversales los enfoques de derechos humanos, género, diversidad sexual, intercultural, generacional y centrado en las necesidades del usuario, que permitan al profesional de salud entablar una relación médico-paciente armónica, respetuosa de las diferencias y en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.

2.4.1. Enfoque de derechos humanos

Implica que todos los seres humanos son considerados iguales y gozan de garantías, libertades y oportunidades, sin discriminación alguna, para preservar su dignidad, bienestar y desarrollo.³

2.4.2. Enfoque de género

Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan, y que determinan un mayor o menor grado de vulnerabilidad.

2.4.3. Enfoque de diversidad sexual

Se basa en el respeto a las manifestaciones de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.

2.4.4. Enfoque intercultural

Reconoce la influencia en la salud sexual y reproductiva de las comunidades de factores culturales, étnicos, costumbres y modos de vida.

2.4.5. Enfoque intergeneracional

Se orienta a considerar las características propias que presentan los diversos grupos generacionales (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) y que tienen influencia en la transmisión de las ITS.

3. Constitución de la República del Ecuador, Sección séptima. Salud, Art. 32. "La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral, salud sexual, salud reproductiva. La prestación de los servicios se regirá en el principio de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad y eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional".



CAPÍTULO III

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

GENERALIDADES

3.1. MODOS DE TRANSMISIÓN

Las formas de transmisión de estas infecciones son las relaciones sexuales sin protección, con o sin penetración vaginal, anal u oral, con una persona infectada. Tienen un mayor riesgo las relaciones sexuales con penetración.

Otros modos de transmisión menos frecuentes incluyen:

- De la madre al niño durante el embarazo, el parto y lactancia (VIH, sífilis).⁴
- Transfusiones u otro contacto con sangre y hemoderivados contaminados.

Es importante tener en cuenta que no toda infección del tracto reproductivo (ITR) es una ITS, ni toda ITS se manifiesta clínicamente como una enfermedad del tracto genital.

4. Guía de manejo de las infecciones de transmisión sexual. Argentina: Programa Nacional de lucha contra los retrovirus del humano, sida y ITS, p. 6.



3.2. ITS FRECUENTES Y SUS AGENTES ETIOLÓGICOS

Cuadro N° 1
Etiología de las ITS

AGENTE ETIOLÓGICO	PATOLOGÍA
Treponema pallidum	Sífilis
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrea
Papiloma virus humano	Condilomas acuminados
Trichomonas vaginalis	Tricomoniasis
Cándida sp.	Candidiasis genital
Virus molusco contagioso	Molusco contagioso
Virus hepatitis B	Hepatitis B
Virus de inmunodeficiencia humana	Infección por VIH, sida
Chlamydia trachomatis	Linfogranuloma inguinal, Uretritis no gonocócica
Herpes virus tipo 1, 2	Herpes genital

3.3. FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE LAS ITS

No todos los casos de contacto sexual sin protección se traducen en la transmisión de una ITS.

3.3.1. Tasa de reproducción de las ITS⁵

Existen distintos factores que influyen en la transmisión de las ITS, que se recogen en la siguiente fórmula que determina la tasa de reproducción de las ITS:

$$R_o = c \times b \times D$$

En esta fórmula, R_o es la tasa de reproducción de las ITS que depende de tres factores:

- c** = Promedio de veces en que ocurre la exposición de las personas susceptibles a las personas infectadas o tasa efectiva media de exposición.
- b** = Probabilidad promedio de que una persona susceptible adquiera la infección al tener un contacto sexual con una persona infectada o eficiencia de transmisión en cada exposición.
- D** = Tiempo promedio que las personas infectadas permanecen infectantes o duración media de la transmisibilidad después de adquirir una infección.⁶

De estos factores, **c** y **D** deben ser abordados por los servicios de salud.

5. Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Sida, *Normas de manejo y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual*, norma técnica N° 46. Santiago de Chile, 2000.
6. *Guía de atención de infecciones de transmisión sexual*. El Salvador: MSPAS: Programa Nacional de ITS - VIH/Sida, 2° edición, junio, 2006, p. 22.



En la consejería se aborda la disminución del número de parejas sexuales, el uso correcto, constante y consistente del condón, acciones que inciden directamente en el factor (c), que de ser cumplidos, disminuyen el riesgo de adquirir una ITS. El tiempo que una persona permanece infectante (D) se disminuye mediante la entrega completa de tratamientos tanto al usuario como a las parejas y contactos; acciones que son de competencia médica y que influyen directamente en la transmisión de las ITS.

3.3.2 Factores condicionantes biológicos

Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de las ITS. Estos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped y la virulencia del agente infeccioso.

Las mujeres jóvenes y adolescentes son más vulnerables que los hombres de su misma edad a las ITS, puesto que la mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes son inmaduros. Además, las mujeres en el climaterio presentan cambios hormonales que también aumentan su vulnerabilidad a las ITS.

Las mujeres tienen mayor riesgo de adquirir ITS por varias razones:

- Mayor superficie de exposición de la mucosa vaginal por la relación sexual receptiva.
- Cambios hormonales en diferentes etapas de la vida.
- Inmunodepresión: menstruación, embarazo.

En los varones los condicionantes biológicos tienen una menor influencia. Sin embargo, la población de varones adolescentes y adultos jóvenes se caracteriza por tener una tasa alta de exposición a las ITS, por presentar una mayor frecuencia de cambio de pareja sexual, un limitado acceso a información preventiva y un menor acceso a los servicios de salud.

3.3.3. Factores conductuales

Muchos factores conductuales podrían afectar las probabilidades de contraer una ITS. Estos factores en su conjunto reciben el nombre de conductas de riesgo y son:

- Cambiar frecuentemente de parejas sexuales.
- Tener más de una pareja sexual.
- Tener contactos sexuales con parejas "casuales".
- Tener contactos sexuales con penetración **sin protección**.
- Haber tenido una ITS durante el último año aumenta el riesgo de volver a contraer la infección si no han cambiado las conductas sexuales.
- El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto sexual disminuye la percepción del riesgo y el uso del condón.

Otras conductas de índole no sexual pueden estar asociadas con el riesgo de contraer algunas ITS, incluyendo el VIH y hepatitis B: uso de agujas sin esterilizar para colocar inyecciones o realizar tatuajes, escarificación, *piercing*⁷ corporal.

7. Perforación voluntaria de algunas zonas del cuerpo para colocación de objetos extraños en zonas como oreja, labio, lengua, nariz, ombligo y genitales.



3.3.4. Factores sociales

Numerosos factores sociales se relacionan con factores conductuales que podrían afectar el riesgo de una persona de contraer una ITS como:

- Conocimientos limitados sobre la prevención de las ITS.
- Limitado acceso al uso de condones masculinos y femeninos.
- Poca capacidad de negociación del uso del condón por parte de la mujer.
- Baja percepción del riesgo y uso inadecuado del condón.
- Actitudes machistas que dificultan el uso de condón en varones.
- Violencia sexual.
- Iniciación precoz de relaciones sexuales.
- Dependencia económica y social de las mujeres.
- Migración interna y externa.
- Concentración de las poblaciones en las ciudades.
- Cambios de valores y costumbres sexuales.
- Actitud permisiva de la sociedad para tolerar a los varones con múltiples parejas sexuales.

3.3.5. Grupos poblacionales prioritarios

Existen determinados grupos de personas en los que las ITS son más frecuentes, ya sea porque están expuestos a parejas infectadas con mayor frecuencia, o porque son más vulnerables a contraer infecciones cada vez que se exponen. Estos grupos incluyen:

- Trabajadoras sexuales, sus parejas y clientes.
- Hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales.
- Hombres o mujeres cuyos trabajos los mantienen alejados de sus parejas durante largos períodos, como conductores de larga distancia, militares y trabajadores migrantes.
- Hombres gay y hombres con comportamiento bisexual (hombres que tienen sexo con hombres).
- Personas trans.
- Personas privadas de libertad y sus parejas.

Grupos de mayor vulnerabilidad a las ITS:

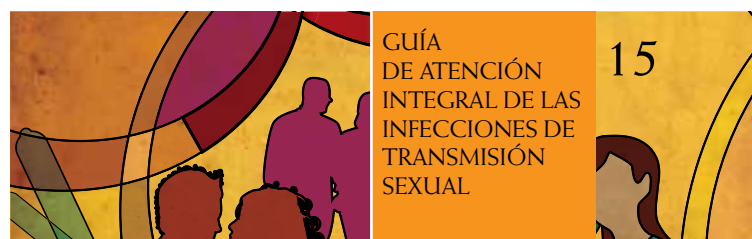
- Niñas o adolescentes abusados sexualmente.
- Adolescentes sexualmente activos.
- Adolescentes o personas con discapacidad intelectual.
- Niñas y niños en situación de calle.

3.3.6. Relación entre las ITS y el VIH

Actualmente existen evidencias que relacionan las ITS y la infección por el VIH. Por ello los servicios de salud dedicados a la atención de las personas con ITS constituyen lugares fundamentales para abordar en forma integral la prevención y diagnóstico del VIH.

Las ITS y el VIH comparten varias características en común:

- Vías de transmisión.
- Estigma y discriminación.
- Estrategias de prevención y promoción de la salud.
- Seguimiento por parte de los programas de control.



La interacción más importante está representada por el efecto facilitador de las ITS en la transmisión del VIH. Muchos estudios reflejan que las ITS ulcerativas (sífilis, herpes, chancroide, etc.) incrementan la transmisión del VIH de 50 a 300 veces⁸ y las no ulcerativas (gonorrea, clamidia, tricomoniasis) incrementan la transmisión del VIH de tres a cinco veces; la C bacteriana incrementa de 1,5 a dos veces.⁹

Las ITS facilitan la transmisión del VIH por:

a) Ruptura de barreras epiteliales de órganos genitales internos y externos:

- Pérdida de la solución de continuidad del epitelio en úlceras genitales.
- Erosiones microscópicas en el cérvix de mujeres debido a procesos inflamatorios, en el caso de gonorrea, tricomoniasis y/o infección por clamidia.

b) Mayor concentración de células, como linfocitos y monocitos, que constituyen un blanco para el VIH, en los procesos inflamatorios de los genitales.

c) Mayor concentración del virus en las secreciones genitales.

3.3.7. Complicaciones de las ITS

La mayoría de las ITS pueden ocasionar complicaciones a hombres y mujeres, aunque las consecuencias en mujeres son más comunes y más graves que en hombres.

3.3.7.1. En las mujeres

Una infección del tracto genital superior puede desarrollarse en cualquier momento, pero las mujeres son más vulnerables inmediatamente después del parto o aborto. Estas infecciones son causas importantes de morbilidad materno-neonatal y son en su mayoría prevenibles.

Las consecuencias más graves de las ITS en las mujeres ocurren cuando una infección del tracto genital inferior (cuello uterino y/o vagina) alcanza el tracto genital superior (útero, trompas de Falopio, ovarios y estructuras adyacentes), causando la llamada enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). La EPI puede cursar con signos y síntomas leves que pueden pasar desapercibidos, sin embargo, puede causar daño tisular cuya cicatrización puede ocasionar infertilidad, dolor pélvico crónico y mayor riesgo de embarazo ectópico.

Se estima que entre el 8 y 10% de los casos de clamidia, y entre el 8 y 20% de los casos de gonorrea diagnosticados progresan a EPI.¹⁰ Entre el 10 y el 23% de mujeres con clamidia y el 15% con gonorrea desarrollan infección del tracto genital superior después de un aborto inseguro.¹¹

El riesgo de infertilidad oscila entre el 15 al 25% después de un episodio de EPI, entre el 50 y el 60% después del tercer episodio.¹² El riesgo de embarazo ectópico es entre seis y diez veces superior en mujeres que han tenido EPI.¹³

8. *Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo*, OMS, p. 18.

9. *Infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida*, Population Council. 2004-04-13, p. 4.

10. *Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo, Una guía para la práctica básica*. OMS, p. 17.

11. *Ibidem*.

12. *Ibidem*.

13. *Ibidem*.



El aborto espontáneo recurrente y la muerte fetal intrauterina, a menudo, son consecuencias de una ITS como la sífilis.

Las ITS pueden ser causa de rotura prematura de membranas, corioamnionitis y parto prematuro.

La infección posparto vaginal es hasta diez veces más frecuente en los países en vías de desarrollo y **explica hasta el 30% de las muertes maternas**.¹⁴

Otras ITS también pueden tener consecuencias graves o fatales. Algunos tipos de papiloma virus humano incrementan en gran medida el riesgo de **cáncer cervical**, siendo esta una de las causas principales de muerte en las mujeres.

3.3.7.2. En los hombres

En el hombre, las complicaciones que se desarrollan con mayor frecuencia después de una infección por gonorrea o clamidia tratada en forma inadecuada son la epididimitis y la cicatrización uretral, que a su vez son causas de infertilidad. Estas complicaciones son prevenibles con un tratamiento adecuado y oportuno.

3.3.7.3. En los recién nacidos

La infección congénita por sífilis, gonorrea, clamidia, virus del herpes simple, hepatitis B o VIH puede ocasionar serias consecuencias para el recién nacido.

La infección por clamidia es una causa importante de **neumonía** en los neonatos.

La infección gonocócica neonatal puede provocar **ceguera**.

La **sífilis congénita** es una causa importante y significativa de morbilidad infantil. Puede ser causa de aborto espontáneo, mortinatos, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, encefalitis, erupción cutánea generalizada, rinitis, disfunción hepática, coagulopatía de consumo y fracaso multiorgánico. Las manifestaciones clínicas tardías incluyen osteítis de huesos largos, tibia en sable, malformaciones maxilofaciales y dentales como dientes de Hutchinson, queratitis intersticial, nariz en silla de montar, retardo mental, hidrocefalia, sordera neurosensorial y déficit neuropsicológico crónico, gomas de pie, paladar alto, mandíbula protuberante, micrognatia, fisuras periorales.¹⁵

El **herpes virus** puede ocasionar aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas, retardo de crecimiento intrauterino, infección intrauterina, herpes neonatal. El 75% de los casos de herpes neonatal son ocasionados por el virus herpes tipo 2.¹⁶

14. Ibídem.

15. Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH y sífilis congénita y manejo de niños y niñas con VIH. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010, p. 38.

16. Virgilio Viera Nieto. Algunas consideraciones especiales sobre herpes virus, consenso de DST 1. p. 108.

CAPÍTULO IV

TIPOS DE MANEJO DE LAS ITS

Las infecciones de transmisión sexual se abordan con tres tipos de manejo:

- Manejo etiológico
- Manejo clínico
- Manejo sindrómico

4.1. MANEJO ETIOLÓGICO

El diagnóstico etiológico a menudo se considera el abordaje ideal en medicina,¹⁷ pero presenta algunas dificultades:

- Las pruebas de laboratorio requieren un tiempo variable conforme al tipo de examen, personal capacitado, infraestructura e insumos, de los que en ocasiones no se dispone en la unidad de atención.
- Las pruebas necesarias tienen un costo que en la mayoría de servicios debe ser sufragado por el usuario.
- Con frecuencia los usuarios deben volver a visitar el servicio de salud para recoger los resultados de las pruebas. Esto conlleva que un importante porcentaje de los pacientes se pierdan sin llegar a recibir el tratamiento, pues no retornan a la consulta.
- El manejo etiológico retarda el inicio del tratamiento hasta disponer de los resultados de laboratorio. Mientras tanto las personas infectadas continúan transmitiendo la infección.

Las pruebas de laboratorio son importantes para el **tamizaje** de infecciones que pueden ser asintomáticas (sobre todo en mujeres embarazadas) para **confirmar el diagnóstico** y para el **seguimiento** de las personas con **ITS complicadas**, como es el caso de la detección de sífilis secundaria en hombres.

17. Módulos de capacitación para manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. Módulo 2, segunda edición. OPS, 2008, p. 3.



4.2. MANEJO CLÍNICO

Mediante el diagnóstico clínico, el profesional de la salud trata las ITS basándose en los síntomas clínicos y su experiencia. Este abordaje también presenta algunas dificultades:

- Algunas ITS causan síntomas similares, por lo tanto, el profesional de la salud podría elegir un tratamiento inadecuado.
- Las infecciones mixtas son comunes y el profesional de la salud podría diagnosticar solo una de ellas. Un usuario con infecciones múltiples necesita ser tratado para cada una de las infecciones.
- Una infección no tratada puede llevar al desarrollo de complicaciones serias y supone que la transmisión continúa.

4.3. MANEJO SINDRÓMICO

Es una estrategia de abordaje eficiente e integral, que se utiliza en muchos países, se adapta fácilmente a cualquier nivel de atención, sobre todo a la atención primaria de salud. Sus características fundamentales son las siguientes:

- Está orientado a resolver las ITS, responde a los síntomas y signos del usuario.
- Es altamente sensible y no omite las infecciones mixtas.
- Permite tratar al usuario en el primer contacto con los servicios de salud, de forma que la atención de las ITS es más accesible al usuario y se implementa en la atención primaria de la salud sin excluir los niveles superiores.
- Utiliza diagramas de flujo que guían al trabajador de la salud a través de pasos lógicos e incluyen las acciones claves.
- Brinda la oportunidad y el tiempo para la educación y la orientación.
- Aprovecha las oportunidades de atención en otros espacios como consulta prenatal, servicios diferenciados de adolescentes, planificación familiar, servicios de urología y dermatología, entre otros.
- Incorpora las 4 C: Consejería, Cumplimiento del tratamiento, atención de Contactos, entrega y capacitación sobre el uso correcto, constante y consistente de Condón.
- En el país añadimos las 3 R: Recordar la oferta de las pruebas de VIH y RPR o VDRL, Registrar y reportar los casos y contactos tratados, y asegurar el Retorno del usuario para control.

DESVENTAJAS

- Requiere capacitación constante para su implementación.
- Dotación permanente de suministros e insumos.
- Implementa un sistema de control de medicamentos desde la bodega central del MSP, bodega provincial, farmacias y botiquines del área de salud; así como el envío de los reportes de uso de los medicamentos, siguiendo la misma ruta hasta el nivel central.
- En algunos casos de ITS, sobre todo en el síndrome de secreción vaginal, puede haber una sobremedicación, por lo que es necesario precisar el diagnóstico.

18. Módulos de capacitación para manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. Módulo 2, segunda edición. OPS; 2008, p. 11.



CAPÍTULO V

MANEJO DE LAS ITS EN ECUADOR

Con el afán de brindar atención a los usuarios con infecciones de transmisión sexual en los niveles I, II y III, se presenta este modelo de atención que incluye realizar el proceso de diagnóstico y tratamiento de forma integral, conforme al flujograma que se expone en el Anexo 2, que describe los pasos a seguir tanto en el abordaje etiológico como sindrómico.

5.1. FLUJOGRAMAS

El flujograma¹⁹ en el manejo de las ITS es un árbol de decisión-acción y sirve de guía para realizar el diagnóstico, confirmar la presencia de una ITS y tratarla de forma etiológica o sindrómica. Además, permite decidir el inicio del tratamiento, consejería, contactos, entrega de condones y lleva a la oferta de la prueba de VIH y VDRL o RPR, notificación y seguimiento del usuario.

El primer paso toma en consideración los signos y síntomas del usuario para identificar el síndrome de ITS correspondiente. Posteriormente el proveedor de salud consulta el flujograma pertinente y, a lo largo de la consulta, va tomando las decisiones y acciones que en él se recomiendan.

Los flujogramas racionalizan la toma de decisiones clínicas, su uso estandariza el diagnóstico, el tratamiento y la referencia. Aseguran que los pacientes con ITS reciban el mismo tratamiento para cada condición en todos los servicios de salud, aumentando la confianza en los mismos. Se representan mediante figuras geométricas que señalan las actividades a realizar, así:

El óvalo corresponde al problema clínico.



El rectángulo corresponde a una acción que significa la ejecución del procedimiento definido.



El hexágono corresponde a una decisión que tiene generalmente varias rutas de salida para señalar posibles acciones a efectuarse.



19. Manual de manejo sindrómico de las ITS, Ecuador: 2007, p. 24.



5.2. ETAPAS DE CONSULTA POR ITS

5.2.1. Entrevista

La entrevista se enmarca en las cuatro etapas de la consulta:

- Elaboración de la historia clínica
- Examen físico integral
- Diagnóstico y tratamiento
- Educación y consejería

5.2.2. Aspectos importantes de la historia clínica

Una elaboración adecuada de la historia clínica incluye los siguientes aspectos:

- Buena técnica de comunicación y calidez en la atención
- Confidencialidad

5.2.2.1. Anamnesis

- Motivo de la consulta
- Antecedentes personales, incluyendo historia sexual
- Antecedentes patológicos personales
- Hábitos y costumbres
- Tratamientos y alergias

Una buena técnica de comunicación ayuda a ganarse la confianza de la persona, dando la bienvenida cuando entra al consultorio, presentándose, mirándola durante la entrevista, escuchándola atentamente y siempre guardando el carácter privado y confidencial de la atención.

Por más ocupado que esté, estructure sus preguntas en forma cortés y respetuosa, no utilice terminología médica, recuerde no emitir juicios de valor, evite hacer preguntas de un modo que usted sugiera las respuestas que espera, deje al usuario que conteste con sus propias palabras.

5.2.2.2. Historia sexual

A continuación se presentan algunas sugerencias de preguntas que deberán ser realizadas conforme la situación de particular de cada usuario. Según las respuestas del usuario, puede ser necesario realizar preguntas complementarias.

- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?
- ¿Número de parejas sexuales que ha tenido usted en el último año?
- ¿Tiene pareja en este momento?
- ¿Ha tenido relaciones sexuales con hombres o mujeres?
- ¿Qué tiempo está con la pareja sexual actual?
- ¿Cuándo fue su última relación sexual?
- ¿Con quién fue su última relación sexual?
- ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses?
- ¿Qué tipo de relaciones sexuales usted realiza? (anales, vaginales, orales)
- ¿Ha tenido síntomas o signos de alguna ITS?



- ¿Recibió tratamiento?
- ¿Qué tipo de tratamiento recibió?
- ¿Por cuántos días recibió tratamiento?
- ¿Usó condón en su última relación sexual?
- ¿Usa regularmente condón en sus relaciones sexuales?
- ¿Se le ha roto algún condón en los tres meses anteriores?

5.2.2.3. Examen físico

El propósito del examen físico es reconocer la presencia de signos y confirmar los síntomas de infecciones de transmisión sexual que nos ayuden al diagnóstico. Al revisar las zonas íntimas del cuerpo de una persona, debe demostrarse sensibilidad y respeto, dado que las personas pueden sentirse avergonzadas o incómodas. Se sugiere explicar al paciente las acciones o procedimientos que se van a llevar a cabo, su objetivo e importancia; así como comunicarle los hallazgos clínicos. Realizar un examen minucioso e integral tanto en hombres como en mujeres nos permite detectar lesiones en boca, piel, mamas y región anoperineal.

- **No olvide adoptar las medidas de bioseguridad universales indicadas para cada procedimiento.**
- **Solicite la presencia de personal de enfermería o acompañante de la usuaria durante el examen, si cree necesario.**

EN HOMBRES

Explique el procedimiento a realizar y obtenga el consentimiento del usuario para luego realizar un examen completo.

Pídale al paciente que se quite la ropa desde el pecho hasta las rodillas.

- Aunque a veces resulta más fácil examinar al paciente acostado, también se puede hacer el examen cuando está de pie.
- Palpe la región inguinal para detectar si tiene o no ganglios linfáticos inflamados.
- Palpe el escroto para sentir cada órgano individualmente: testículos-conducto deferente-epidídimo.
- Examine el pene, en busca de lesiones como erupciones, verrugas o úlceras, pídale que se retraiga el prepucio y observe el glande y el meato urinario.
- Si no puede ver secreciones obvias en la uretra, pídale que se exprima el pene para provocar secreción uretral.
- Examine el ano en busca de secreción, verrugas, ulceración u otro signo; la región púbica en busca de ectoparásitos.
- Examine orofaringe conforme a las prácticas sexuales.
- Informe al usuario los hallazgos y registre en la historia clínica.



EN MUJERES

- Explique el procedimiento a realizar y obtenga el consentimiento de la usuaria para luego realizar un examen ginecológico completo.
- Pida a la paciente que se quite la ropa desde la cintura hacia abajo y que se acueste en la camilla. Cubra con una sábana la zona del cuerpo que no examinará.
- Pídale que doble las rodillas y separe las piernas para examinar la vulva, el ano y el periné en busca de úlceras, verrugas o ectoparásitos.
- Palpe la región inguinal para detectar si tiene o no ganglios linfáticos inflamados.
- Palpe con cuidado el abdomen en busca de tumoraciones pelvianas y dolor.
- Registre la presencia o ausencia de verrugas, ectoparásitos, úlceras, secreción vaginal, su tipo, olor, color y cantidad.
- Examine la vagina y el cérvix, que incluye el examen bimanual e instrumental en busca de signos de cervicitis.
- Examine el ano en busca de secreción, verrugas, ulceración u otro signo.
- Examine orofaringe conforme a las prácticas sexuales.
- No olvide examinar mamas.
- Informe a la usuaria los hallazgos y registre.



CAPÍTULO VI

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS CON MANEJO SINDRÓMICO

Los síndromes que se describen en la presente guía son:

1. Síndrome de úlcera genital
2. Síndrome de secreción uretral
3. Síndrome de secreción vaginal
4. Síndrome de dolor abdominal bajo
5. Síndrome de edema de escroto
6. Síndrome de bubón inguinal
7. Síndrome de conjuntivitis neonatal

6.1. SÍNDROME DE ÚLCERA GENITAL

Definición

La úlcera genital representa la pérdida de continuidad de la piel y/o mucosa de los órganos genitales o de las áreas adyacentes. En ocasiones se inicia con la presencia de vesículas que evolucionan a úlceras.

El usuario refiere una "llaga" o "herida" en sus genitales. Puede ser dolorosa o indolora, puede o no acompañarse de linfadenopatía inguinal, puede provocar ardor y/o quemazón en contacto con orina, agua, jabón y/o en la relación sexual.

Etiología

Las ITS que producen el síndrome de úlcera genital son:

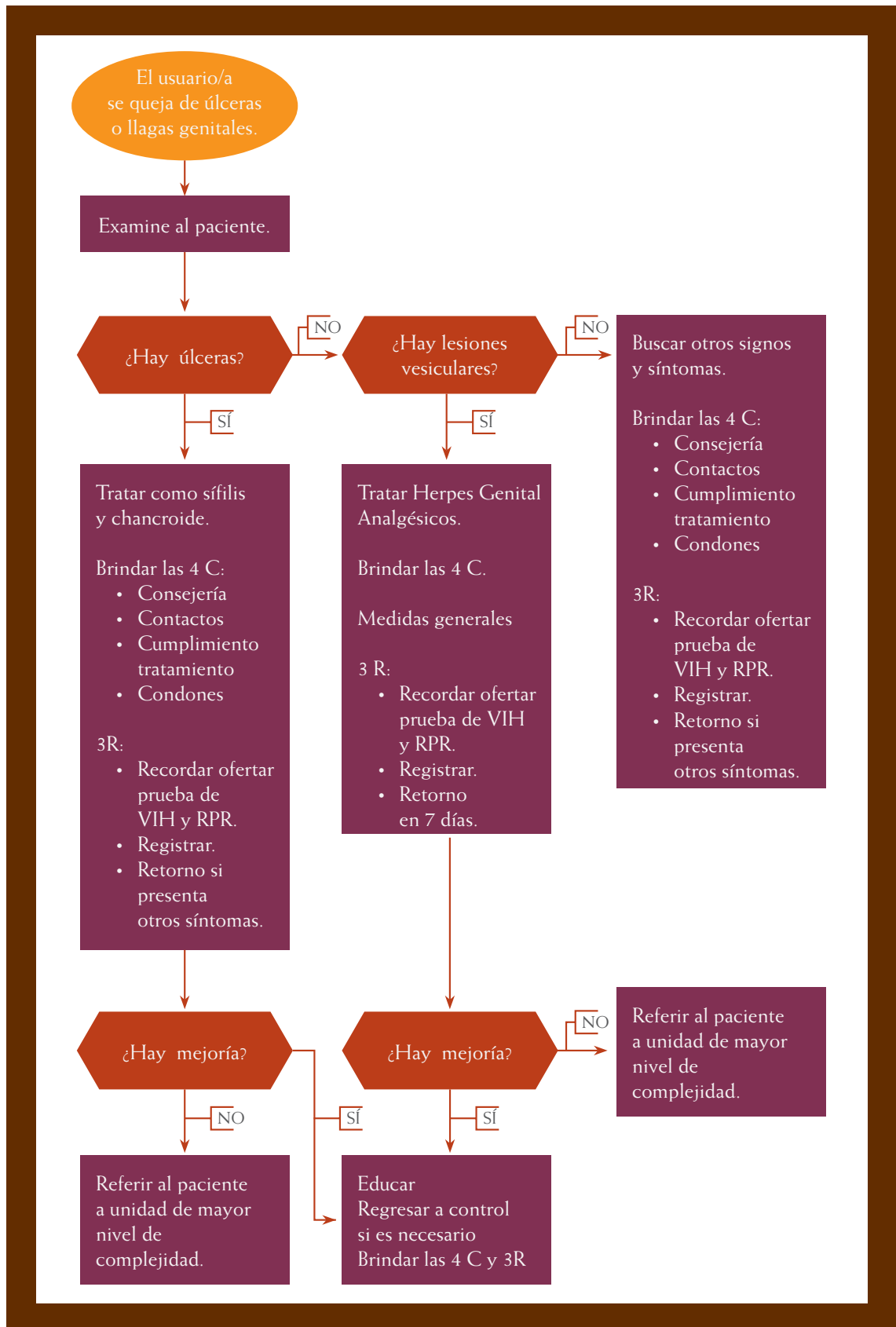
- Sífilis primaria causada por el *Treponema pallidum*.
- Chancroide o chancro blando causado por el *Haemophilus ducrey*.
- Herpes genital causado por el virus herpes simple, tipo 1 y 2. El tipo 2 es más frecuente.

El síndrome úlcera genital incluye **dos subsíndromes**:

- Síndrome de úlcera producida por sífilis y chancroide.
- Síndrome de úlcera precedida de vesícula, producida por el herpes genital.



FLUJOGRAMA 1 MANEJO DEL SÍNDROME DE ÚLCERA GENITAL



6.1.1. Síndrome de úlcera producida por sífilis y chancroide

Las úlceras²⁰ indoloras, de bordes regulares y de consistencia dura al tacto, pueden corresponder a sífilis; si son varias, muy dolorosas, de bordes irregulares, de fondo sucio (secreción purulenta) y blandas al tacto nos orienta a pensar en chancro blando. El tratamiento se realiza con:

**Penicilina benzatínica 2.400.000 UI vía intramuscular, dosis única;
+
Azitromicina 500 mg, 2 tabletas, dosis única**

En mujeres gestantes utilizar el mismo esquema de tratamiento.²¹ En caso de alergia a la penicilina en una mujer embarazada referir a unidad de mayor complejidad para desensibilización²² (capítulo 8, página 57).

En varones y mujeres no embarazadas con alergia a la penicilina se pueden utilizar los siguientes medicamentos, que son también efectivos para tratar chancro blando:

- tetraciclina 500 mg, cada 6 horas por 7 días²³
 - o
- doxiciclina 100 mg vía oral, cada 12 horas por 7 días
 - o
- sulfametoxazol + trimetoprin 800/160, cada 12 horas por 7 días.

Si las lesiones se presentan por más de cuatro semanas, se debe sospechar de donovanosis o linfogranuloma venéreo. En estos casos, se utilizan los medicamentos ya anotados por 21 días.

La consejería al usuario incluye el énfasis en la importancia de completar el tratamiento, abstenerse de relaciones sexuales hasta que desaparezcan las lesiones, ofertar seguimiento periódico del usuario por un año, y la realización de pruebas de VIH y de VDRL o RPR.

6.1.2. Síndrome de úlcera precedida de vesícula producida por herpes genital

Se caracteriza por presentar lesiones cubiertas por varias vesículas,²⁴ que pueden confluir en una ampolla delgada, frágil, que se rompe con facilidad, dejando una úlcera de bordes irregulares²⁵ en algunos casos sobreinfectada. En otros casos se observan varias úlceras individuales. Se acompaña de ardor y dolor tipo quemazón, puede haber adenopatía y generalmente el usuario refiere haber tenido episodios similares con anterioridad.

No existe tratamiento curativo para el herpes genital, las lesiones suelen ser recurrentes.

Se administra tratamiento cuando se realiza el diagnóstico. Si las lesiones se detectan en la fase vesicular de la primoinfección, el tratamiento puede evitar recidivas. El tratamiento se realiza con:

Aciclovir 400 mg, una tableta cada 8 horas vía oral por 7 días.

20. Fotos 1, 3 y 4.

21. Directrices para os tratamentos das doenças sexualmente transmissíveis. MMWR 04/08/06. www.cdc.gov

22. Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH y sífilis congénita y manejo de niños y niñas con VIH. Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 2010, p. 38.

23. Control das doenças sexualmente transmissíveis. Ministerio da Saúde Brasil; 2006, p. 45.

24. Foto N° 16.

25. Fotos N° 17, 18, 19 y 20.



Además, se brinda tratamiento sintomático para el dolor, evitando los AINES.

En caso de recurrencias mayores a tres veces en el año, realizar tratamiento supresor con aciclovir 400 mg, dos veces al día, por un año.

Se recomienda mantener limpia y seca la zona afectada por las lesiones y suspender las relaciones sexuales mientras las lesiones no hayan desaparecido completamente. Es importante saber que, aunque la persona no tenga síntomas, todavía puede infectar a sus parejas sexuales. Se debe indicar a las parejas sexuales de las personas infectadas que pueden contagiarse y que deben usar condones para reducir el riesgo.

En mujeres gestantes la infección se debe tratar en cualquier trimestre de la gestación.

En aquellos casos en los que las lesiones son muy extensas se debe sospechar coinfección con VIH y ofertar la prueba. Si el resultado es negativo, recuerde recomendar al usuario que se repita la prueba en tres meses y usar condón en todas las relaciones sexuales.

Se debe tratar a todo contacto o pareja dentro de los 90 días de exposición, aunque no presente sintomatología, y hacer seguimiento del paciente durante un año.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.

6.2. SÍNDROME DE SECRECIÓN URETRAL

Definición

La presencia de secreción uretral en los hombres,²⁶ con o sin dolor al orinar, comprobada con el prepucio retraído, o si es necesario, por la compresión de la raíz del pene en dirección al glande, debe ser considerado como un caso de secreción uretral.

La secreción uretral es la queja más común de ITS en hombres, representa una uretritis o infección de la uretra. Se caracteriza por presentar secreción o fluido por la uretra de tipo purulento o mucoso, claro, blanquecino o amarillo verdoso abundante o escaso, en algunas ocasiones solo mancha la ropa interior.²⁷

En ocasiones las infecciones son asintomáticas.

Etiología

Los agentes asociados son:

- *Neisseria gonorrhoeae*.
- *Chlamydia trachomatis*.

Ocasionalmente la *Trichomonas vaginalis* puede ser el agente responsable.

26. Fotos N° 18, 19, 20, 21.

27. Foto N° 26.



Tratamiento del síndrome de secreción uretral

El tratamiento correcto para la secreción uretral debe incluir medicamentos para la **gonorrea** y **clamidiasis**, puesto que estos microorganismos pueden coexistir en un mismo paciente hasta en un 40% de los casos. En lo posible el tratamiento debe ser directamente observado.

El tratamiento se realiza con:

Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dosis única.
+
Azitromicina 500 mg, dos tabletas en dosis única.

Tratamientos alternativos

- Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg²⁸ vía intramuscular, dosis única
 - o
- espectinomicina 2 g, vía intramuscular, dosis única
 - o
- gentamicina 280 mg vía intramuscular, dosis única.
 - +
- Para clamidia: doxiciclina 100 mg, vía oral, cada 12 horas por 7 días
 - o
- tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días
 - o
- eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días.

En caso de persistencia de la secreción o recidiva, descartar falta de adherencia al no haber cumplido con la dosis indicada de tratamiento, o reinfección al tener relaciones con pareja no tratada o nuevas sin condón. Si el usuario se halla en alguna de las circunstancias descritas se trata de un caso de recidiva, por lo que lo indicado es repetir el tratamiento al usuario y contactos. Si ha cumplido con el tratamiento de forma completa, ha tomado la medicación su pareja y no ha tenido pareja nueva o bien ha usado condón, puede tratarse de una infección por trichomonas, que se debe tratar con:

Metronidazol 4 tabletas de 500 mg en dosis única por vía oral.

Si no hay mejoría, remitir al usuario a una unidad operativa de nivel superior.

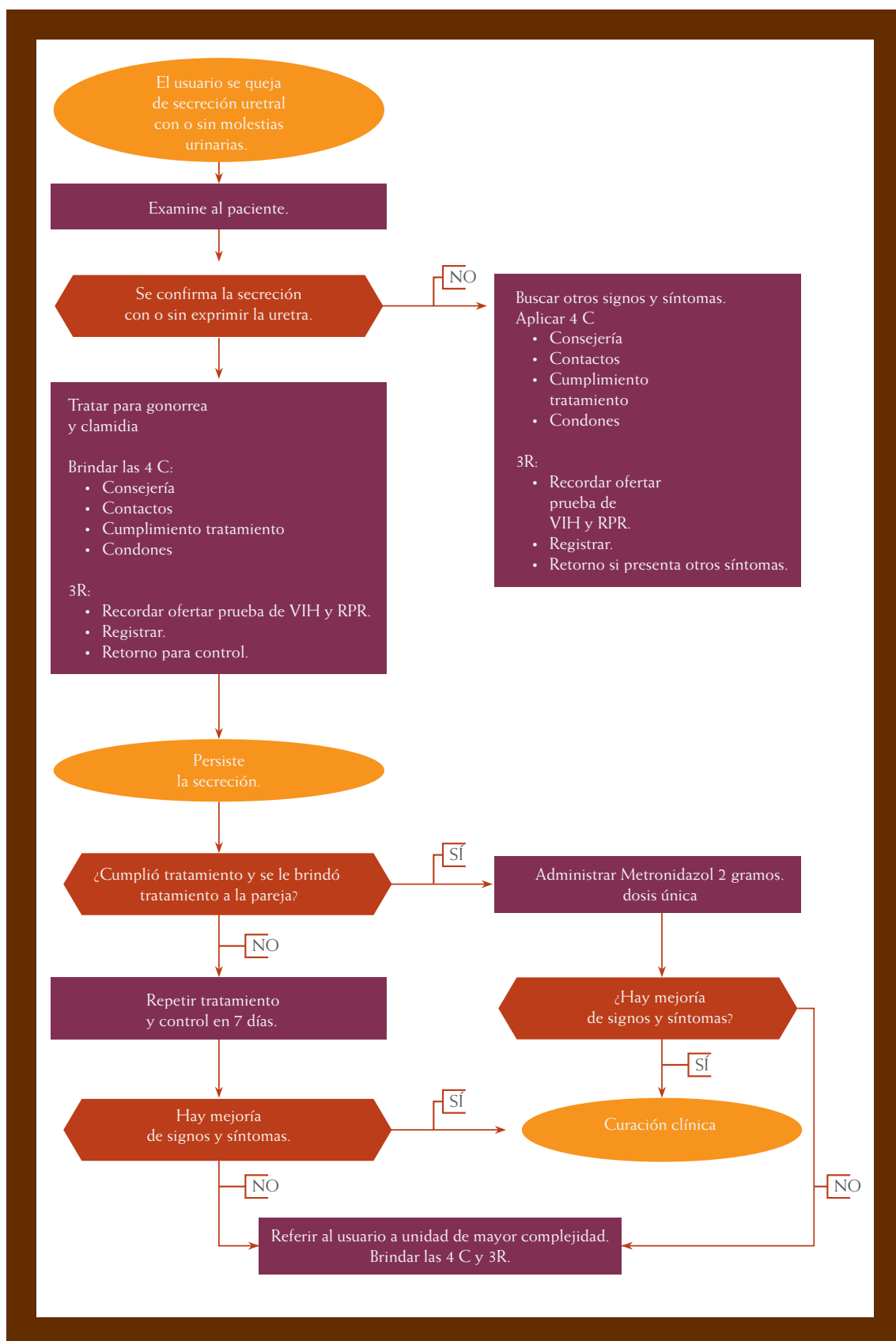
Las parejas sexuales deben ser tratadas con iguales medicamentos y esquemas **aunque no tengan manifestaciones clínicas**. Las personas que toman metronidazol no deben ingerir licor durante 72 horas después de la toma del medicamento.

Los pacientes con VIH que presentan este síndrome deben tomar el mismo tratamiento propuesto. No olvide cumplir las **4 C** y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.

28. Doenças sexualmente transmissíveis. Brasil: Ministério de Saúde; p. 48.



FLUJOGRAMA 2 MANEJO DE SÍNDROME DE SECRECIÓN URETRAL



6.3. SÍNDROME DE SECRECIÓN VAGINAL

Definición

Se considera síndrome de secreción vaginal al aumento en la cantidad de la secreción, con cambio de color, mal olor, a veces acompañado o no de prurito, o irritación vulvar, en algunos casos con disuria, dispareunia. Cuando a este cuadro se añade el dolor en el hemiabdomen inferior, este deberá ser manejado como síndrome de dolor abdominal bajo.

Se debe considerar que la mujer presenta un flujo vaginal normal que deriva de la trasudación de fluidos de los vasos capilares de la vagina mezclados con secreciones de las glándulas de Bartholino y de Skene, del endometrio, de las trompas de Falopio y del cerviz. Además, la vagina presenta un conjunto de microorganismos que viven normalmente en ella y se denomina flora vaginal. Este ecosistema vaginal con pH 3,5 a 4 se mantiene en equilibrio, pero **puede ser alterado por duchas vaginales, espermicidas, uso de antisépticos, antibióticos, anticonceptivos, embarazo o enfermedades subyacentes como diabetes**, que deberán ser valoradas en casos de recidiva.

El síndrome de secreción vaginal incluye dos subsíndromes que son:

- cervicitis
- vaginitis

6.3.1. Cervicitis

Etiología

- Gonorrea²⁹ causada por *Neisseria gonorrhoeae*.
- Clamidia³⁰ causada por *Chlamydia trachomatis*.

Es importante señalar que en una misma mujer pueden coexistir ambas entidades, vaginitis y cervicitis. Es difícil distinguir una cervicitis de una vaginitis cuando no se puede hacer un examen ginecológico completo, por lo que se recomienda considerar los siguientes factores de riesgo de cervicitis:

- Pareja con síntomas de ITS.
- Tener relaciones sexuales sin uso de condón con más de una pareja sexual en los últimos tres meses.
- Tener una pareja nueva en los últimos tres meses.
- No uso o rotura de condón en alguna relación sexual.³¹

Es fundamental el **examen ginecológico con espéculo** para diferenciar entre vaginitis y cervicitis. Además, se preguntará la existencia o no de dolor abdominal bajo en los últimos tres meses; en caso de obtener respuestas positivas, se debe seguir el flujograma respectivo.

29. Foto N° 22.

30. Foro N° 27.

31. *Doenças sexualmente transmissíveis (DST)*. Brasil: Ministerio de Saúde-SVS-Programa Nacional de DST/AIDS; segunda edición, p. 54.



Tratamiento

El tratamiento de cervicitis incluye medicamentos para gonorrea y clamidiasis y consiste en:

Ciprofloxacina 500 mg, una tableta, dosis única
+
Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis única

Tratamientos alternativos

- Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dosis única
o
- espectinomicina 2 g, intramuscular, dosis única
o
- gentamicina 280 mg, intramuscular, dosis única.
+
- Para clamidia: doxiciclina 100 mg, vía oral, cada 12 horas por 7 días
o
- tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días.
o
- eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días.

6.3.2. Vaginitis

Etiología

- Tricomoniasis genital causada por *Trichomonas vaginalis*.³²
- Vaginosis bacteriana frecuentemente asociado a *Gardenerella vaginalis*³³ y otros microorganismos anaerobios.
- Candidiasis³⁴ causada por *Cándida albicans*.

Los profesionales de la salud deben indicar a la usuaria evitar los antisépticos vaginales en forma de duchas, los protectores diarios, los tampones vaginales realizados con materiales no estériles, las prendas de vestir muy ajustadas (nailon, lycras); así mismo, se debe recomendar el cambio frecuente de tampones vaginales. Es importante también indicar que se deben suspender las relaciones sexuales mientras dura el tratamiento, usar condón, no suspender el tratamiento por la presencia de menstruación.

Tratamiento

El tratamiento de vaginitis incluye medicamentos para la tricomoniasis, candidiasis y vaginosis bacteriana:

Clotrimazol 200 mg, vía vaginal, 1 vez antes dormir por 3 noches
+
Metronidazol 500 mg, 4 tabletas, dosis única

32. Foto N° 29.

33. Foto N° 30.

34. Foto N° 28.



Tratamientos alternativos

- Para tricomoniasis: metronidazol 2 g, vía oral, dosis única
o
- tinidazol 2 g, vía oral, dosis única
o
- secnidazol 2 g, vía oral, dosis única.
+
- Para vaginosis bacteriana: metronidazol 2 g, vía oral, dosis única
o
- clindamicina, vía vaginal 1 vez al día por 7 días.
+
- Para candidiasis: nistatina 100.000 u, vía vaginal 1 vez al día por 14 días
o
- fluconazol 150 mg, vía oral, dosis única.

Contraindicaciones

- Durante el primer trimestre del embarazo no usar metronidazol.
- Durante todo el embarazo no usar ciprofloxacina, doxiciclina y gentamicina.
- En menores de 16 años y en mujeres dando de lactar, no administrar ciprofloxacina.

Tratamiento de la secreción vaginal en gestantes

Los principios del tratamiento de la secreción vaginal en la gestante son los mismos que en mujeres no embarazadas, es decir, se tratará la vaginitis, la cervicitis o ambas, dependiendo de los datos obtenidos en el interrogatorio y en el examen físico y valoración de riesgo.

No se olvide de cumplir con la cuarta C; la usuaria por estar embarazada no deja de tener relaciones sexuales y puede tener parejas nuevas, por lo que se debe insistir en el uso constante y consistente del condón.

Tratamiento de la vaginitis en gestantes

Se deben incluir medicamentos para las tres causas más frecuentes de vaginitis: tricomoniasis, vaginosis bacteriana y candidiasis.

Metronidazol * 2 g, en una dosis única, vía oral

+

Clotrimazol 200 mg, 1 óvulo vaginal cada noche, por 5 noches

* El metronidazol se utiliza a partir de las 12 semanas de gestación.

Tratamiento de la cervicitis en gestantes

Incluye medicamentos para la gonorrea y clamydiasis:

Espectinomicina 2 g, dosis única, intramuscular

+

Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis única



Tratamientos alternativos

Para cervicitis:

- Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg dosis única, intramuscular.
+
- Para clamydiasis: eritromicina 500 mg, cada 6 horas por 7 días.

Para vaginitis:

- Para tricomoniasis + vaginosis bacteriana: metronidazol 250 mg, vía oral, cada 8 horas por 7 días.
+
- Para candidiasis: nistatina 100.000 UI 1 tab. Vag., por 14 noches.

Tratamiento de las parejas sexuales

Tratar a las parejas sexuales (de gestantes y de no gestantes) contra tricomoniasis, administrando metronidazol 2 g, en una dosis oral única, o secnidazol o tinidazol 2 g, vía oral, dosis única.

No consumir bebidas alcohólicas mientras se tome metronidazol u otros imidazólicos hasta por 72 horas después de la última dosis.

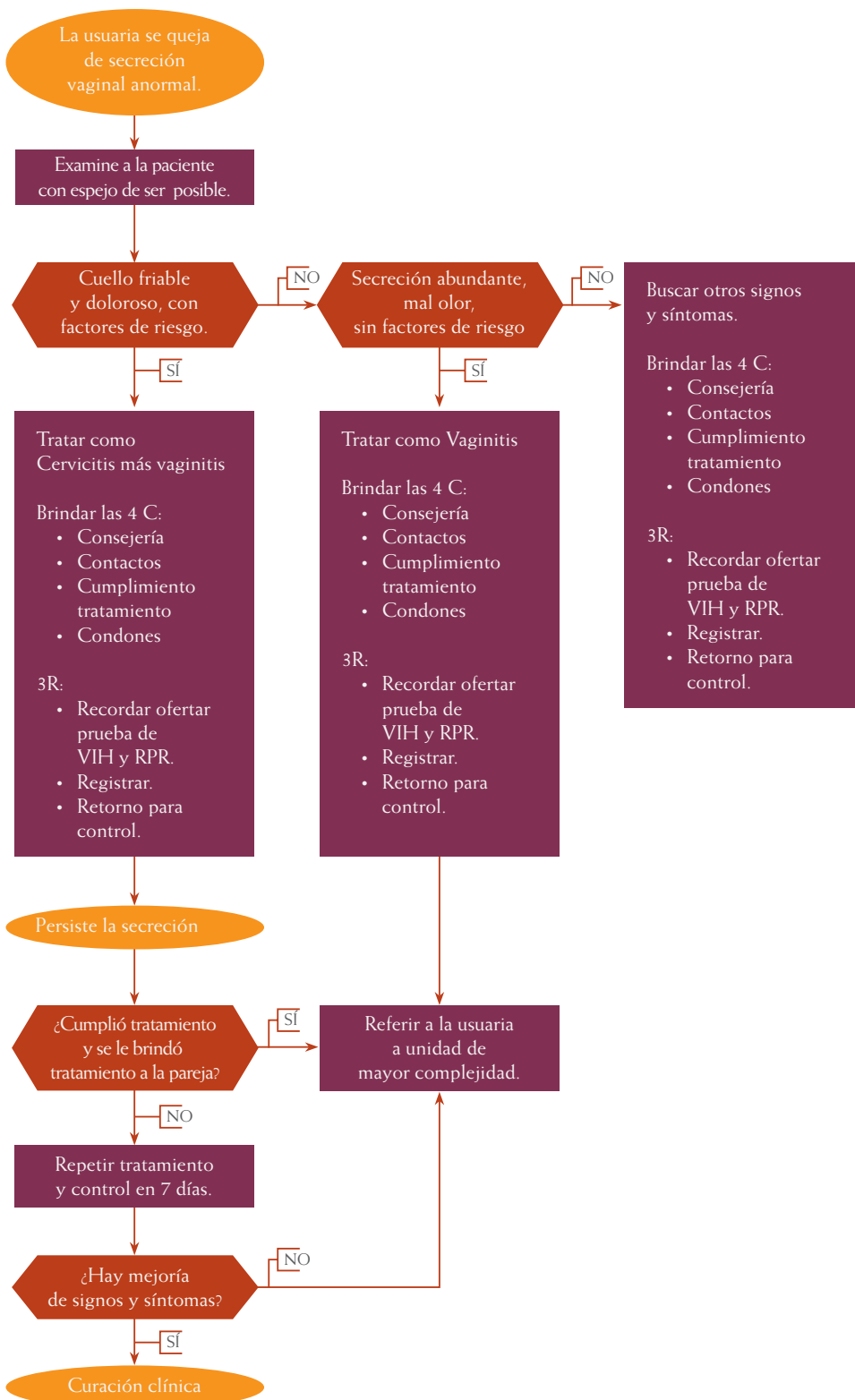
Todas las parejas sexuales (de gestantes o no gestantes) tratadas por cervicitis deberán recibir tratamiento para evitar la recurrencia. En el caso de personas con VIH se empleará igual esquema de tratamiento.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.



FLUJOGRAMA 3

MANEJO DEL SÍNDROME DE SECRECIÓN VAGINAL



6.4. SÍNDROME DE DOLOR ABDOMINAL BAJO

Definición

Es el dolor de origen pélvico, que se intensifica con las menstruaciones, las relaciones sexuales, con la actividad física y tiene irradiación a la parte baja del abdomen, que puede estar acompañado o no de flujo vaginal anormal, fiebre y dolor a los movimientos de lateralización del cérvix. Conduce al diagnóstico presuntivo de **enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)**, que es la infección de los órganos reproductivos internos que afecta frecuentemente a mujeres sexualmente activas.

El diagnóstico diferencial incluye emergencias clínico-quirúrgicas:

- Embarazo ectópico
- Apendicitis aguda
- Pielonefritis aguda
- Litiasis uretral
- Torsión de tumor quístico de ovario
- Endometritis
- Peritonitis
- Entidades colon-rectales

Ante la sospecha diagnóstica de cualquiera de las entidades arriba mencionadas, referir inmediatamente a una unidad con capacidad resolutive. No utilizar AINES.

Etiología

Es producido por microorganismos transmitidos sexualmente como:

- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Chlamydia trachomatis*
- Bacterias anaerobias
- Otros como *mycoplasma hominis*, bacilos Gram negativos

El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es poco preciso, está basado en los hallazgos clínicos y características epidemiológicas, depende de la experticia del examinador. Es necesario conocer la clasificación de la EIP, porque en el manejo sindrómico se abordarán solo los casos que se encuentran en el **estadio I**; a partir del estadio II se debe referir a una unidad de salud con capacidad de resolución.

Clasificación de la EIP

- Estadio I (leve): salpingitis³⁵ aguda sin irritación peritoneal.
- Estadio II (moderada sin absceso): salpingitis con irritación peritoneal (pelvi peritonitis).
- Estadio III (moderada con absceso): salpingitis aguda con oclusión tubárica o absceso tubo-ovárico o absceso pélvico.
- Estadio IV (grave): absceso tubo-ovárico roto o signos de *shock* séptico.

35. Fotos N° 31 y 32.

Tratamiento de la EIP

El tratamiento de EIP estadio I se realiza luego de haber descartado las emergencias clínico-quirúrgicas, siguiendo el siguiente esquema recomendado:

Ciprofloxacina 500 mg, una tableta, dosis única
+
Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis única
+ metronidazol 500 mg, 4 tabletas, dosis única

Tratamientos alternativos

- Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dosis única
o
- espectinomicina 2 g, intramuscular, dosis única
o
- gentamicina 280 mg, intramuscular, dosis única
+
- Para clamidiasis: doxiciclina 100 g, vía oral, cada 12 horas por 14 días
o
- tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 14 días
o
- tritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 10 días.
+
- Para bacterias anaerobias: metronidazol 500 mg, vía oral, cada 12 horas por 15 días
o
- clindamicina, vía vaginal, 1 vez al día por 7 días
o
- clindamicina 600 mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días.

Contraindicaciones

- En el primer trimestre de gestación: metronidazol
- Durante todo el embarazo: ciprofloxacina, doxiciclina y gentamicina
- En menores de 16 años y madres en etapa de lactancia: ciprofloxacina

Seguimiento

Las mujeres que reciben tratamiento ambulatorio de EIP deben ser evaluadas a las 24 horas de iniciado el tratamiento. De no haber mejoría clínica, deberán ser remitidas de manera urgente a una unidad operativa de mayor complejidad.

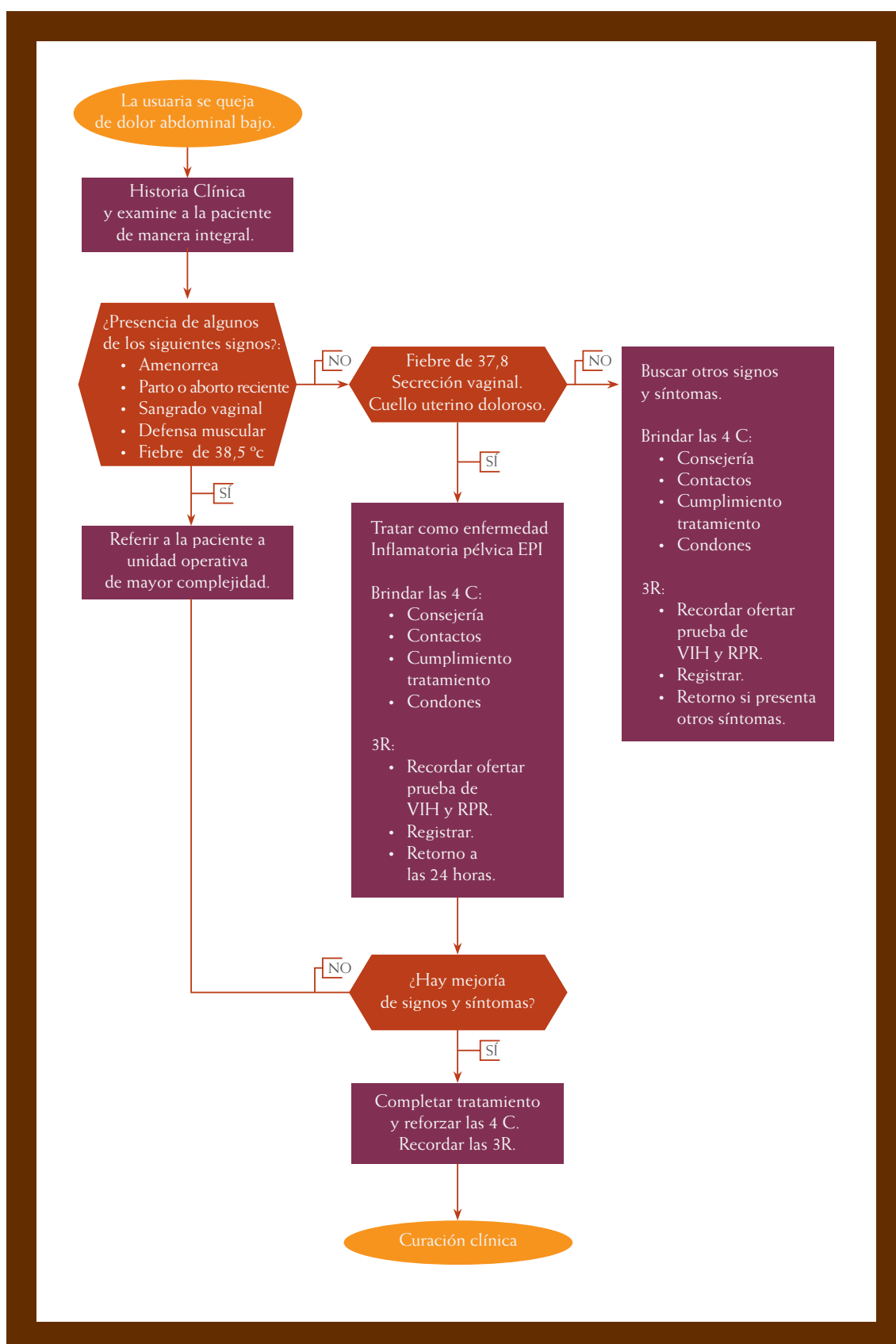
Manejo de contactos

En toda pareja que hubiere tenido relaciones sexuales con la paciente en los últimos 60 días, se debe administrar el tratamiento recomendado para el síndrome de secreción uretral. No se olvide recomendar suspender las relaciones sexuales y el uso de condón.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.



FLUJOGRAMA 4 MANEJO DEL SÍNDROME DE DOLOR ABDOMINAL BAJO



6.5. SÍNDROME DE EDEMA DE ESCROTO

Definición

Hinchazón (edema), acompañado de dolor en escroto, es generalmente unilateral, de inicio insidioso y progresivo secundario a relaciones sexuales sin protección.

Etiología

Las ITS que provocan edema de escroto son:

- Gonorrea causada por *Neisseria gonorrhoeae*
- Clamidia causada por *Chlamydia trachomatis*

Si el usuario presenta edema de escroto³⁶ puede corresponder a una ITS, pero es necesario descartar otros cuadros como trauma testicular, torsión testicular, varicocele, hidrocele, hernia inguinoescrotal, orquitis por otros gérmenes (parotiditis), tumores.

La presencia de edema de escroto, junto con factores de riesgo confirmados, se considera secundario a una ITS.

Tratamiento

Ciprofloxacina 500 mg, una tableta, dosis única
+
Azitromicina 500 mg, 2 tabletas, dosis única

Tratamientos alternativos

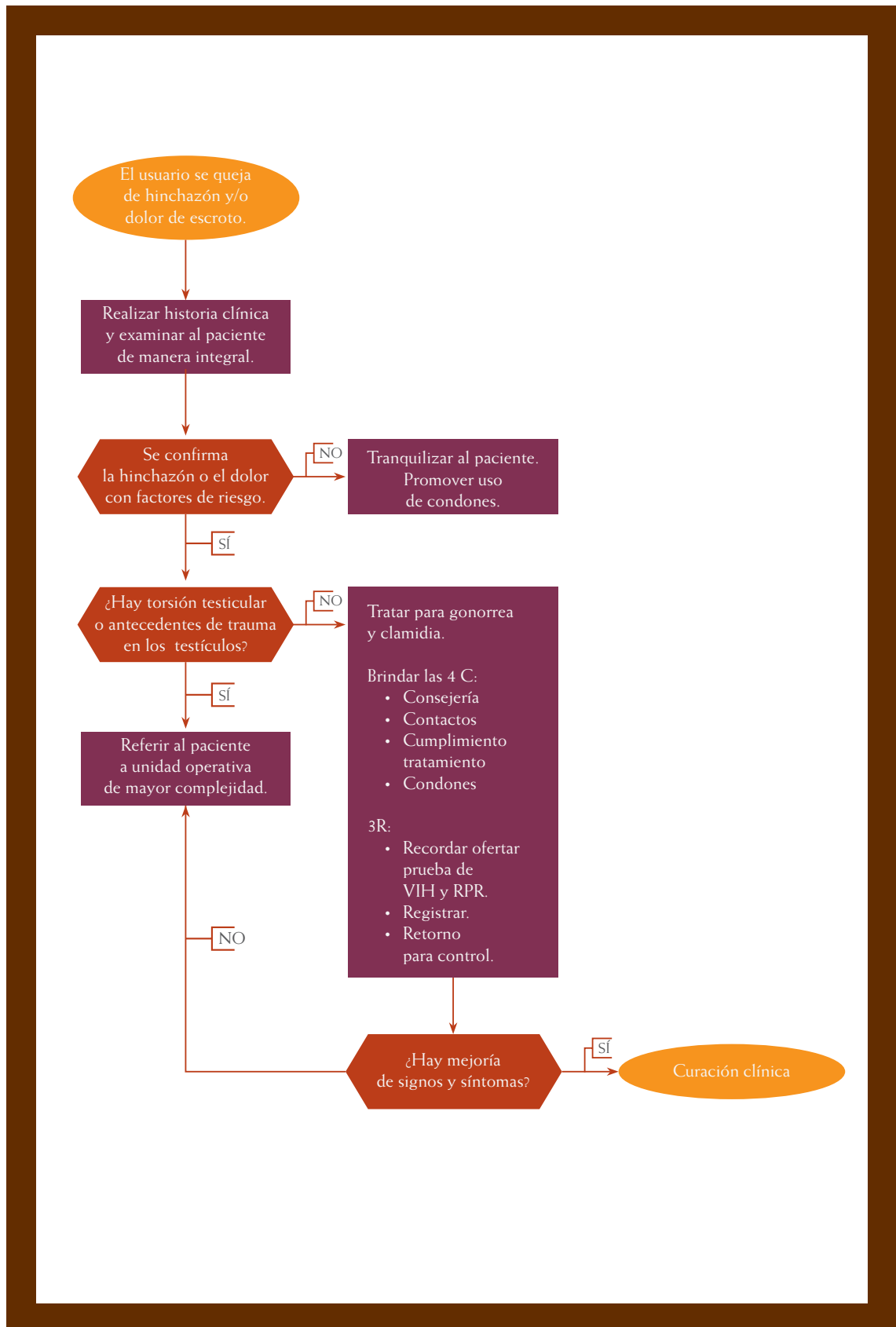
- Para gonorrea: ceftriaxona de 250 mg, intramuscular, dosis única
 - o
- espectinomicina 2 g, intramuscular, dosis única
 - o
- gentamicina 280 mg, intramuscular, dosis única.
 - +
- Para clamidia: doxiciclina 100 mg, vía oral, cada 12 horas por 14 días
 - o
- tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 14 días
 - o
- eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 10 días.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.

36. Foto N° 33.



FLUJOGRAMA 5. MANEJO DEL SÍNDROME DE EDEMA DE ESCROTO



6.6. SÍNDROME DE BUBÓN INGUINAL

Definición

Es la presencia de una masa fluctuante,³⁷ con o sin dolor en la región inguinal uni o bilateral, acompañada de historia reciente de lesión ulcerativa en genitales y posterior a contacto sexual sin protección.

Etiología

Las ITS responsables de producir bubón inguinal son:

- Linfogranuloma venéreo causada por *Chlamydia trachomatis*.
- Chancro blando causada por el *Haemophilus ducreyi*.

Si el usuario presenta bubón inguinal doloroso y fluctuante, en ausencia de úlcera genital, este signo puede corresponder a linfogranuloma venéreo. Por otra parte, el conjunto de un bubón y úlceras genitales indica la sospecha de chancroide y requiere que el proveedor de salud consulte y siga el flujograma para síndrome de úlcera genital.

Tratamiento

Se realiza con:

Doxiciclina 100 mg, vía oral, cada 12 horas por 21 días

Tratamientos alternativos

- Eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 21 días
 - o
- tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 21 días
 - o
- trimetoprim sulfá 160/800 mg, vía oral, cada 12 horas por 14 días.

Contraindicado el drenaje a cielo abierto por el riesgo de favorecer el apareamiento de ulceraciones de difícil cicatrización. En caso de bubón fluctuante, se puede realizar aspiración con aguja N° 18 o catéter N° 14 en el sitio más blando. El usuario necesita tratamiento para el dolor y soporte emocional.

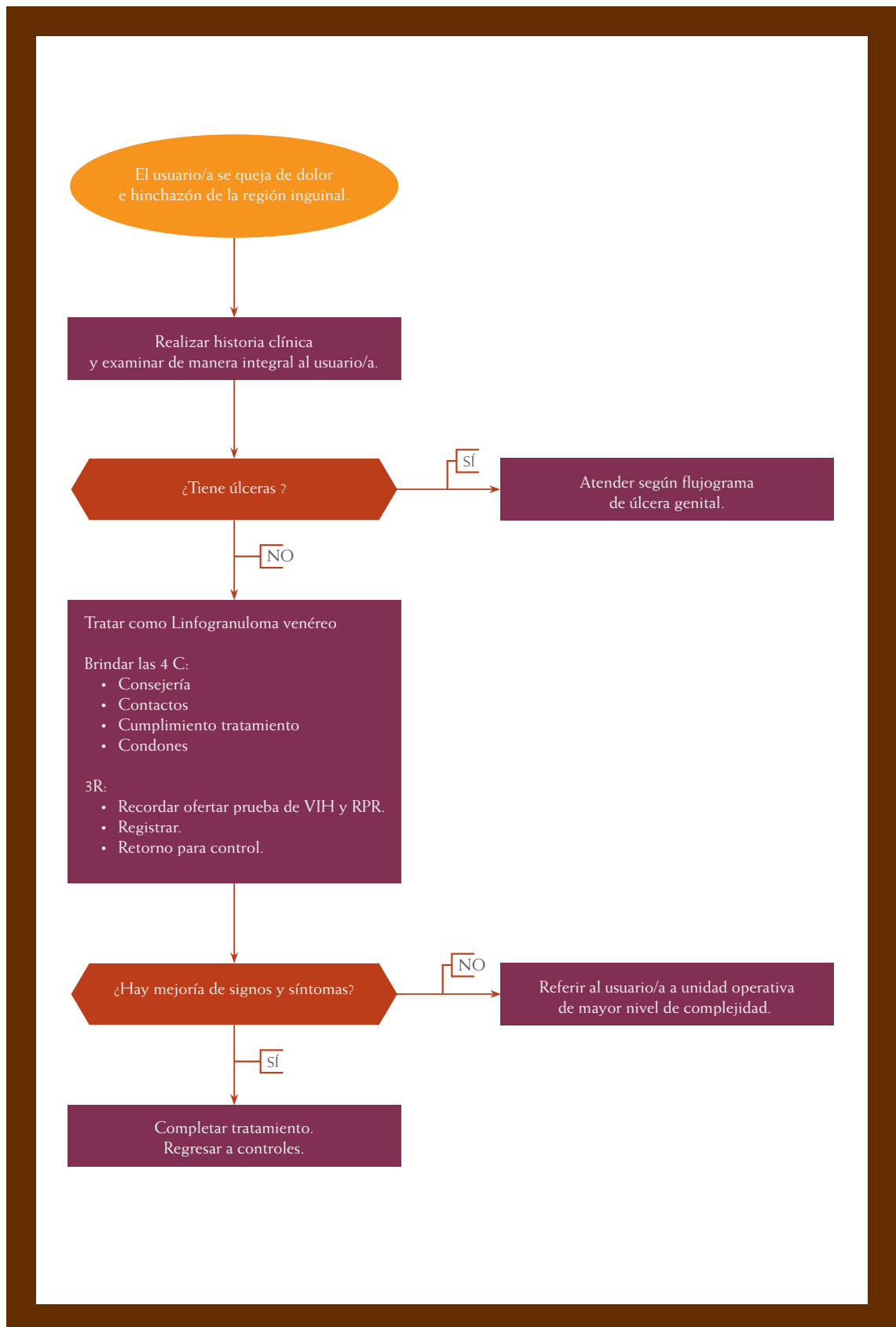
El tratamiento a la pareja se debe realizar con igual esquema. En este caso el usuario debe asistir a controles sucesivos a las 48 o 72 horas, para valoración del tratamiento.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.

37. Fotos N° 34 y 35.



FLUJOGRAMA 6 MANEJO DEL SÍNDROME DE BUBÓN INGUINAL



6.7. CONJUNTIVITIS NEONATAL

Definición

Un neonato menor de un mes de edad que tiene los ojos hinchados y enrojecidos.³⁸

Las principales ITS responsables de conjuntivitis neonatal son:

- Gonorrea causada por *Neisseria gonorrhoeae*
- Clamidia causada por *Chlamydia trachomatis*

Tratamiento

El tratamiento se realiza con:

**Ceftriaxona 25 a 50 mg por kg de peso
hasta un máximo de 125 mg en dosis única, intramuscular**

Tratamiento alternativo

Espectinomicina 25 mg por kg de peso, máximo de 75 mg en dosis única intramuscular.

Recomendar a la madre limpiar las secreciones oculares con suero fisiológico, infusión de manzanilla y control al neonato en 48 horas. Si no existe mejoría, se debe iniciar tratamiento pensando en clamidia.

El tratamiento para clamidia se realiza con:

**Eritromicina (susp.) 50 mg por kg de peso/día,
vía oral, cada 6 horas por 14 días**

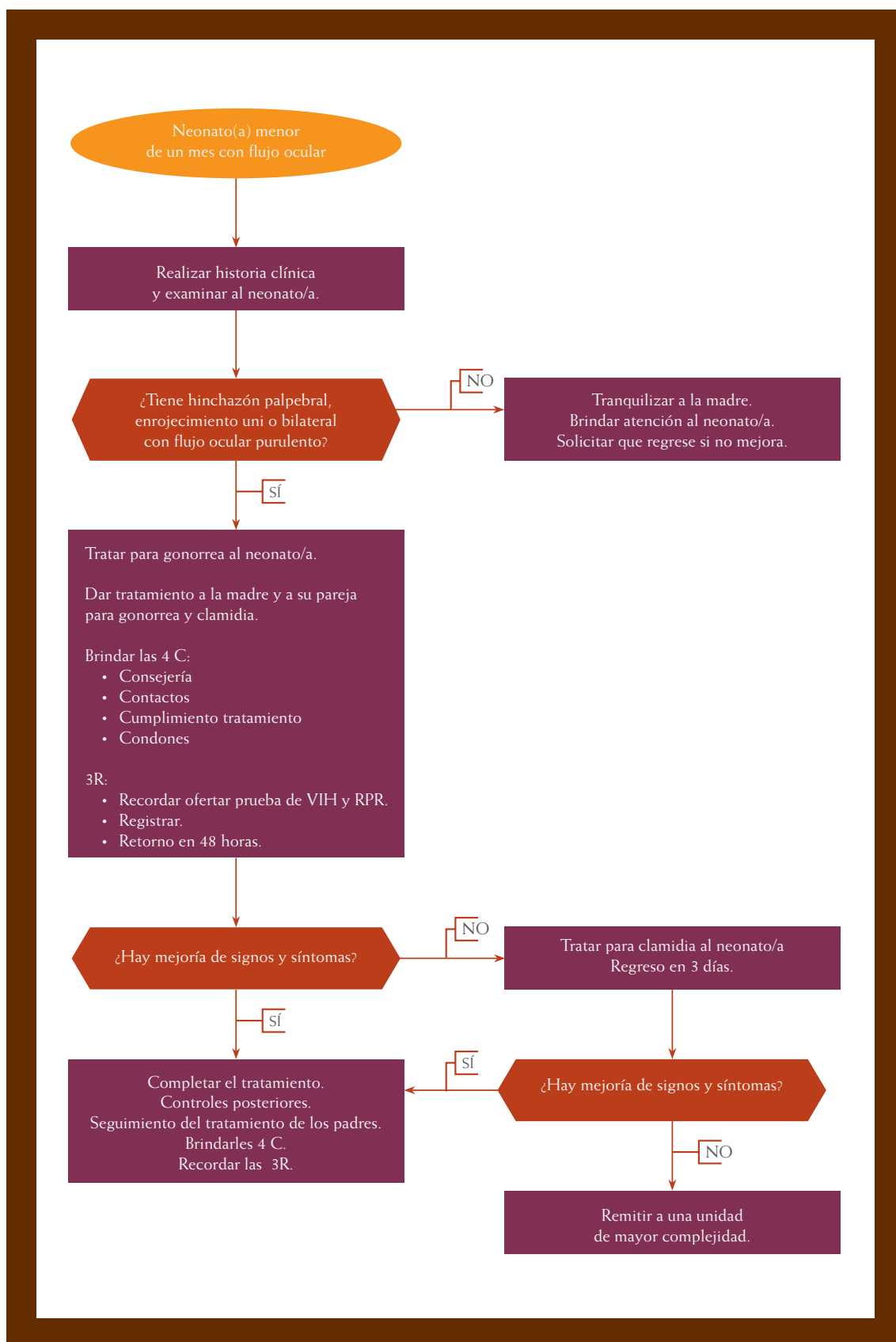
En este caso, el tratamiento incluye atender a la madre y su pareja, quienes deben recibir tratamiento para gonorrea y clamidia. Se debe pedir a la madre que regrese con el neonato en siete días para control.

No olvide cumplir las 4 C y Recuerde en todas las atenciones ofertar a los padres la prueba de VIH y VDRL o RPR, Registrar la atención y asegurar el Retorno con una nueva cita para evaluar el tratamiento.

38. Foto N° 36.



FLUJOGRAMA 7 MANEJO DEL SÍNDROME DE CONJUNTIVITIS NEONATAL



CAPÍTULO VII

ABORDAJE ETIOLÓGICO DE LAS ITS

El abordaje etiológico se hará en unidades que dispongan del servicio de laboratorio. No reemplaza al manejo sindrómico de las ITS al momento de la administración de tratamiento. El resultado etiológico se utilizará para la confirmación de la sospecha diagnóstica y para la evaluación del tratamiento, que ha sido orientado por el manejo sindrómico. El manejo etiológico de las ITS también aporta evidencia para la vigilancia de los agentes etiológicos, causantes de las diversas entidades patológicas.

Se procederá a atender las ITS de la siguiente forma:

- Definición del problema clínico.
- Realización de historia clínica.
- Historia de vida sexual.
- Valoración de riesgo.
- Examen físico completo.
- Impresión diagnóstica.
- Toma de muestras en el consultorio previo a la administración del tratamiento.
- Coordinar el envío de la muestra a laboratorio.
- Tratamiento Completo para todas las patologías más frecuentes.
- Consejería de ITS.
- Demostración y entrega de Condones.
- Atención a Contactos.
- Recuerde ofertar la prueba de VIH y RPR.
- Registro de la atención.
- Realizar citas para control, para revisión de resultados y tratamiento.



Se considera el abordaje etiológico de las siguientes entidades patológicas:

1. Gonorrea
2. Clamidiasis
3. Papiloma virus humano
4. Candidiasis
5. Tricomoniasis
6. Vaginosis bacteriana
7. Hepatitis B
8. Sífilis (capítulo 8)

7.1. GONORREA

7.1.1. Definición

Es la infección producida por un diplococo Gram negativo³⁹ conocido como *Neisseria gonorrhoea*, que se caracteriza en el hombre por la presencia de uretritis con secreción purulenta, en la mujer suele ser asintomática a menos que ocasione una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Existen otras localizaciones (faríngea y anal), que dependen de las prácticas sexuales. La conjuntivitis neonatal por gonococo es la consecuencia de un canal vaginal infectado durante el parto.

Esta entidad es **una** de las causas de varios síndromes:

- Síndrome de secreción uretral
- Síndrome de edema de escroto
- Síndrome de secreción vaginal en el subsíndrome de cervicitis
- Síndrome de dolor abdominal bajo
- Síndrome de conjuntivitis neonatal

7.1.2. Toma de muestras

La muestra será tomada de la secreción uretral, cérvix y fondo de saco vaginal, anal, faríngea u ocular; tomada preferentemente por el personal médico y remitida inmediatamente al laboratorio para realizar técnicas de Gram, fresco y cultivo. El transporte de la muestra se realiza en el medio de Stuart Amies, que mantiene los inóculos hasta un máximo de ocho horas. Cuando no existe el medio adecuado para transportar la muestra, se debe proceder a realizar frotis para Gram en el consultorio y enviar al laboratorio. En el caso de secreciones anales, se debe evitar la contaminación con materia fecal.

7.1.3. Procedimiento de laboratorio

1. En la tinción de Gram se valora:

- a) N° de polimorfonucleares (PMN) por campo. Se considera anormal un recuento **mayor a 4 PMN/campo** (si la toma se realizó después de la micción, puede ocurrir que no se vean PMN pese a que haya uretritis). **En la uretritis gonocócica (UG) suele haber más de 50 PMN/campo.**
- b) El **valor diagnóstico** está dado por la presencia de **diplococos Gram negativos dentro de los PMN**. Estos se visualizan en el 95% de los pacientes varones con UG.

39. Foto N° 19.



2. Leucocito esterasa en orina: En pacientes en los que se sospecha de uretritis gonocócica y no hay suficiente material para toma de muestra, se puede evidenciar la presencia de inflamación a través de la detección de la **enzima leucocito esterasa** en orina. La muestra será una orina al azar. Esta prueba está incluida en numerosos kits comerciales.
3. Cultivo de secreciones: El cultivo en medios apropiados para gonococo como **Thayer Martin** o **agar chocolate suplementado** es de utilidad cuando se requiere confirmación. Es económico, aunque **requiere cumplir con condiciones anaerobias**, por lo que puede complicarse el procedimiento.
4. Amplificación de ácido nucleicos (NAAT) para *neisseria gonorrhoeae*: Es el "gold estándar" para el diagnóstico de uretritis, la amplificación con sondas génicas del material genético de *N. gonorrhoeae*. Esta prueba está indicada en pacientes con evidencia de uretritis, leucoesterasa positivo (1+ o más) y sin secreción.

7.1.4. Tratamiento

En todos los casos se debe administrar el tratamiento conjunta para **gonorrea y clamidia**, por la presencia de infecciones mixtas en hasta el 40% de los casos.

7.2. CLAMIDIASIS

7.2.1. Definición

Es la infección producida por el microorganismo *Chlamydia trachomatis*⁴⁰ que se caracteriza en el hombre por la presencia de uretritis inespecíficas, en la mujer suele ser asintomática a menos que ocasione una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

Se ha encontrado asociada hasta en el 62% de infecciones por *neisseria gonorrhoeae*, en mujeres y hasta en el 4 a 7% de mujeres con displasia cervical. Cada vez son más numerosas las pruebas de la etiología por clamidia de la cervicitis, en porcentajes que ascienden hasta el 36%.

Dentro de los subtipos de *chlamydia trachomatis* encontramos los que producen el linfogranuloma venéreo y la conjuntivitis de inclusión.

Es una de las causas de los síndromes que se detallan a continuación:

- Síndromes de secreción uretral
- Síndrome de secreción vaginal en el subsíndrome de cervicitis
- Síndrome de dolor abdominal bajo
- Síndrome de edema de escroto
- Síndrome de conjuntivitis neonatal

7.2.2. Toma de muestras

Las muestras serán de la secreción uretral, vaginal o anal. Serán tomadas preferentemente por el personal médico y remitidas inmediatamente al laboratorio para PCR en tiempo real (disponible en el INH de Guayaquil).

40. Fotos N° 26 y 27.



7.2.3. Procedimiento de laboratorio

El cultivo es costoso, laborioso y de poca utilidad clínica, por lo que se ha establecido la necesidad de contar con técnicas de biología molecular como PCR⁴¹ para clamidia, lo que apoya el diagnóstico clínico. En las diversas secreciones, la presencia de polimorfonucleares entre 4 y 50 por campo puede ser orientador a UNG.⁴²

7.2.4. Tratamiento

En todos los casos se debe administrar el tratamiento conjunto para gonorrea y clamidia, por la presencia de infecciones mixtas en hasta el 40% de los casos.

7.3. HERPES GENITAL

7.3.1. Definición

El herpes genital es una infección viral, caracterizada por vesículas, ampollas o úlceras muy dolorosas, generalmente localizado en los genitales externos⁴³ o en los glúteos y de evolución recurrente. La localización de estas lesiones es independiente de la puerta de entrada, por la disposición de los nervios.

El síndrome que causa es el de úlcera genital.

7.3.2. Toma de muestras

El diagnóstico de la infección herpética es básicamente clínico. Se pueden tomar muestras de sangre para estudio serológico de IgG e IgM para herpes II.

7.3.3. Interpretación de resultados y diagnóstico etiológico

La diferenciación entre primoinfección y recurrencia se hace por laboratorio, al medir la IgG y la IgM para herpes II. En la primoinfección la IgG es negativa y la IgM puede ser positiva o negativa. En las recurrencias la IgG siempre es positiva.

En usuarios de alto riesgo con parejas que no han evidenciado primoinfección, se debe establecer el estatus serológico de la pareja y valorar el riesgo de recurrencias.

7.3.4. Tratamiento

El tratamiento se realiza con aciclovir 400 mg, cada ocho horas por siete días.

En los casos de recurrencias, más de tres episodios en el año o en el caso de parejas serodiscordantes, se utilizará el tratamiento supresivo con aciclovir 400 mg cada 12 horas⁴⁴ por al menos un año.^{45, 46}

41. PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.

42. UNG: Uretritis no gonocócica.

43. Fotos N° 13,14,15,16 y 17.

44. Tratamiento supresivo para herpes genital recurrente. MMWR 04/08/06 (RR-11), 94. www.cdc.gov.

45. El manual de la OPS no es concluyente sobre el tiempo de administración de tratamiento de supresión. Acogemos la sugerencia de realizarlo por un año y evaluar la respuesta.

46. Guía para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. OMS, p. 51-53.



7.4. CONDILOMA POR PAPILOMA VIRUS (VERRUGA VENÉREA)

7.4.1. Definición

Es una infección producida por el virus del papiloma humano (HPV). Se caracteriza por presentar lesiones de diferentes características, algunas planas,⁴⁷ de tamaño variable, con aspecto de "coliflor" (verrugas, *mitchas*,⁴⁸ crestas de gallo), indoloras, en la piel y en la mucosa de las áreas genitales internas, externas o anales.

El período de incubación es de tres semanas a ocho meses, con un promedio de tres meses. Se conocen más de 100 serotipos diferentes del HPV, de los cuales 30 de ellos pueden infectar la región genital. Los serotipos 11 y 6 son los que más frecuentemente causan lesiones en los seres humanos. Los serotipos 16, 18, 31, 33, 35, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82 se consideran oncogénicos.⁴⁹

El 80% de la población ha estado en contacto con el virus del papiloma humano con curación espontánea de las lesiones.⁵⁰

En los últimos tiempos la enfermedad ha aumentado significativamente y se conoce muy bien su asociación directa con displasia de diferentes grados y cáncer del cuello uterino. La infección en el hombre puede pasar inadvertida por la ausencia de síntomas que permitan su detección. En el niño se puede presentar papilomatosis laríngea cuando ha sido expuesto a un canal de parto infectado. Se reportan casos de carcinoma genital y anal en el hombre relacionados con este virus.

7.4.2. Toma de muestra

Se recomienda realizar una toma de muestra de cuello de útero, que es analizada por tinción de PAP, para la estadificación en grados según Bethesda. Además, deben tomarse muestras para la determinación de serotipos. En pacientes de alto riesgo o con una citología sugestiva de HPV, se debe realizar una colposcopia, androscopia, rectoscopia o uretroscopia y considerar la posibilidad de biopsia.

7.4.3. Interpretación de resultados y diagnóstico etiológico

En grupos seleccionados de pacientes con citología normal o moderadamente inflamatoria y que poseen alto riesgo de contraer la infección por HPV, se ha encontrado que las biopsias de zonas sospechosas tienen un mejor valor predictivo al momento de diagnosticar la infección.

En caso de tratarse de HPV el seguimiento del PAP test será cada seis meses.

7.4.4. Tratamiento

Se realiza en los servicios de atención integral en salud sexual (SAISS), en centros de segundo y tercer nivel. En caso de lesiones vegetantes macroscópicas se debe utilizar criocuagulación. Otros métodos de tratamiento son la aplicación de ácido tricloroacético entre el 60 y 80%, una vez

47. Fotos N° 31 y 38.

48. Nombres populares con los que se conoce la infección de papiloma virus humano.

49. Directrices para el tratamiento de las ITS. MMWR 04/08/ 2006-55 (RR- 11), 1-94. www.cdc.gov.

50. Directrices para el tratamiento de las ITS. MMWR 04/08/2006-55 (RR- 11), 94. www.cdc.gov.



por semana; podofilina entre el 10 y 25%, una vez por semana hasta la resolución de las lesiones. Recordar que la podofilina está contraindicada en mujeres embarazadas y no aplicar en mucosas. Al utilizar estas preparaciones se debe tener la precaución de proteger la piel circundante a la lesión con vaselina o sulfadiazina de plata. La aplicación la debe hacer personal entrenado, en ningún caso el paciente. Se han reportado lesiones erosivas por autoadministración de sustancias ácidas. Se recomienda lavar la lesión después de dos a cuatro horas de la aplicación del tratamiento.

En estos usuarios se debe siempre ofertar la prueba de VIH, VDRL o RPR, por su frecuente asociación.

7.5. CANDIDIASIS VAGINAL

7.5.1. Definición

Es la infección del tracto genital femenino por especies de hongos del género *Cándida*.⁵¹ Es uno de los agentes causantes del síndrome de secreción vaginal y, en ocasiones, en el hombre de secreción uretral y/o balanopostitis.

La secreción se caracteriza por ser de color blanco como leche cortada, puede hallarse en el canal vaginal, incluso cubrir el cuello. Al limpiar la secreción, esta nunca viene del cuello. Si no hay sobreinfección, no tiene olor.

7.5.2. Toma de muestras

Se toma una muestra de la secreción cérvico vaginal o del pene para examen en fresco. Ocasionalmente se solicitará un cultivo, sobre todo en aquellos casos en que falle el tratamiento administrado.

7.5.3. Procedimiento de laboratorio

El examen se realiza en fresco con solución salina al 0,9% o hidróxido de potasio al 10% o por citología. El cultivo se realiza en agar adecuado (Sabouraud, Nickerson) para el crecimiento e identificación del germen.

7.5.4. Interpretación y diagnóstico etiológico

En el examen en fresco, la presencia de levaduras o pseudohifas determina la presencia de *Cándida*. Sin embargo, para la determinación de la especie se requiere cultivo e identificación a través de pruebas bioquímicas.

7.5.5. Tratamiento

Se hace con fluconazol 150 mg una sola dosis (contraindicado en el embarazo) o clotrimazol al 1 o 2% en crema, óvulos o tabletas vaginales, una vez cada noche por tres días en las no embarazadas y en las embarazadas crema vaginal al 1%, una vez por la noche de tres a cinco noches.

En la balanopostitis, clotrimazol tópico dos veces al día, hasta una semana después de la desaparición de lesiones; se recomienda suministrar dosis única de fluconazol de 150 mg.

Otras alternativas de tratamiento son itraconazol, ketoconazol, nistatina.

51. Foto N° 28.

7.6. TRICOMONIASIS

7.6.1. Definición

Es una infección causada por el protozoo llamado trichomonas vaginales, un parásito unicelular flagelado, anaerobio facultativo y solo existe en forma de trofozoito. Afecta el tracto genital femenino y excepcionalmente a la uretra distal del hombre. En las mujeres embarazadas puede ser causa de **amenaza de aborto, ruptura prematura de membranas y parto prematuro**.

Se presenta en forma de síndrome de secreción vaginal acompañada de intenso prurito vulvovaginal.⁵²

En los hombres la infección generalmente cursa de forma asintomática.

7.6.2. Toma de muestras

Visualización del agente causal, mediante el examen en fresco del frotis de las secreciones o mediante el examen citológico. En el caso de que la muestra de secreciones no vaya a ser analizada inmediatamente, debe ser transportada en solución salina al 0,9% estéril.

7.6.3. Tratamiento

Se utiliza metronidazol 2 g en una sola toma o secnidazol 2 g en dosis única, o tinidazol 2 g en dosis única. Tratar a la pareja con el mismo esquema.

En caso de recurrencia, dar metronidazol 500 mg cada ocho horas por siete días.

No consumir alcohol, hasta 72 horas después del tratamiento.

7.7. VAGINOSIS BACTERIANA

7.7.1. Definición

Este nombre se da a una afección que ocurre en las mujeres, cuando el equilibrio bacteriano normal en la vagina⁵³ se ve alterado por uso indebido de duchas vaginales, productos antisépticos vaginales, protectores diarios, etc.

Hay crecimiento excesivo de bacterias anaerobias, entre otros organismos *Gardnerella vaginalis*, *Haemophilus vaginalis*, *Corynebacterium vaginalis*, *Mycoplasma*.

7.7.2. Criterios diagnósticos

Los criterios de Amsel indican que para considerar un caso de vaginosis bacteriana deben cumplirse al menos tres de los cuatro criterios que siguen:

- Leucorrea homogénea, pastosa y blanca.
- Identificar al microscopio células clave.
- PH superior a 4,5.
- Olor a pescado al añadir hidróxido de potasio (KOH al 10%).

52. Foto N° 29.

53. Foto N° 30.



7.7.3. Tratamiento

Metronidazol 2 g en una sola toma o secnidazol 2 g en dosis única, o tinidazol 2 g en dosis única.

Tratar a la pareja con el mismo esquema.

No consumir alcohol, hasta 72 horas después del tratamiento.

Clindamicina crema vaginal, tabletas u óvulos al 2% vía intravaginal cada noche por siete noches.

En caso de recurrencia valorar hábitos higiénicos, prácticas sexuales, uso de medicamentos.

7.8. HEPATITIS B

7.8.1. Definiciones

Es la infección causada por el virus de hepatitis B y cuyo espectro clínico va desde la hepatitis aguda⁵⁴ autolimitada, hasta la hepatitis crónica que puede llegar a cáncer hepático.

La transmisibilidad a través del contacto sexual llega a ser superior a la del VIH.

7.8.2. Toma de muestra

El diagnóstico se hace en suero sanguíneo, con pruebas de detección del antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg), los anticuerpos antiantígeno de superficie (anti-HBs) y los anticuerpos contra el core (anti-HBc total) constituyen el tamizaje inicial para hepatitis B. Los anticuerpos contra el core del virus de hepatitis B IgG e IgM (anti-HBc IgG e IgM) sirven para la discriminación entre hepatitis aguda y crónica y el antígeno de envoltura y su respectivo anticuerpo (HBe, anti-HBe) son indicativos de replicación viral activa.

54. Foto N° 42.

7.8.3. Interpretación y diagnóstico etiológico

La interpretación de las pruebas de hepatitis B se resume en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2
Interpretación de las pruebas de hepatitis B

RESULTADO	INTERPRETACIÓN
HBsAg: negativo Anti-HBs: negativo	Paciente susceptible, sugerir vacunación
HBsAg: positivo Anti-HBs: negativo Anti-HBc total e IgM: positivos	Hepatitis B aguda
HBsAg: positivo Anti-HBs: negativo Anti-HBc total: positivo Anti-HBc IgM: negativos	Hepatitis B crónica
HBsAg: negativo Anti-HBs: positivo Anti-HBc total: positivo	Inmune por infección natural (paciente se infectó y curó espontáneamente)
HBsAg: negativo Anti-HBs: positivo Anti-HBc total: negativo	Inmune por vacunación
Otros patrones	Se pueden deber a diferencias en las técnicas, variabilidad genética del virus cuyas proteínas no son detectadas por las pruebas disponibles, en estas situaciones se debe solicitar el HBeAg y anti-HBe.

El antígeno de envoltura (HBe) es reflejo de replicación viral activa y de progresión de la infección. El mejor indicador de la posibilidad de cronificación de la infección es la carga viral para virus de hepatitis B por técnicas como DNA.

7.8.4. Tratamiento

El tratamiento de la hepatitis B se valora de acuerdo a la fase en la que se encuentra.

La hepatitis B aguda no debe recibir tratamiento específico, únicamente de sostén.

En la hepatitis B crónica debe valorarse la presencia de replicación viral, el componente inflamatorio (GOT-GPT) y la progresión a cirrosis (Child Pugh B) para proveer tratamiento que lleve a una disminución de la replicación viral.

Debe considerarse, además, el estatus serológico para VIH, pues al momento de escoger drogas para el tratamiento de hepatitis B, existen drogas que tienen acción antirretroviral.

Si el paciente requiere tratamiento antirretroviral concomitante o no tiene VIH, utilizar un régimen que contenga por lo menos dos drogas con acción anti hepatitis B y con acción antirretroviral (tenofovir, lamivudina o emtricitabina).

Si es un paciente con VIH y no requiere tratamiento antirretroviral concomitante, utilizar un régimen que contenga drogas únicamente con actividad anti hepatitis B como adenofovir e interferón.



CAPITULO VIII

SÍFILIS

8.1. DEFINICIÓN

Es la enfermedad producida por la espiroqueta *treponema pallidum*,⁵⁵ con un período de incubación de 10 a 90 días, con promedio de 21 días. La sífilis es una enfermedad sistémica desde el inicio y puede clasificarse como congénita o adquirida.

La sífilis adquirida se divide en temprana y tardía.

Sífilis temprana: es aquella que tiene una evolución de menos de dos años.

- **Primaria:** se caracteriza por la presencia de una lesión ulcerada, generalmente única, indolora, seca, conocida como **chancro sifilítico**,⁵⁶ desaparece de manera espontánea entre una y dos semanas. Esta fase se relaciona con el síndrome de úlcera genital.
- **Secundaria:** caracterizada por lesiones mucocutáneas⁵⁷ que incluyen palma de manos y planta de pies y adenopatías. Es una de las etapas más infectantes de la enfermedad. Puede aparecer entre seis semanas y seis meses después del chancro y puede desaparecer de manera espontánea entre una y dos semanas.
- **Latente temprana o latente precoz:** no hay manifestaciones clínicas y el diagnóstico se hace por estudios serológicos.

Sífilis tardía: es aquella con evolución mayor de dos años.

- **Sífilis latente tardía:** no hay manifestaciones clínicas, los exámenes serológicos son positivos y se trata como sífilis terciaria. En caso de no poder discriminar entre una temprana o tardía, se debe tratar como esta última.
- **Sífilis terciaria:**⁵⁸ se caracteriza por afectaciones cardiovasculares (aortitis, insuficiencia cardíaca) y/o neurosífilis.

55. Foto N° 2.

56. Fotos N° 1, 3, 4.

57. Fotos N° 4, 6, 7, 8 y 10.

58. Foto N° 11.



CONSIDERACIONES ESPECIALES

- **Sífilis gestacional:** en la mujer embarazada se presenta con manifestaciones severas como abortos repetitivos, retardo de crecimiento intrauterino y muerte neonatal.
- **Sífilis congénita:**⁵⁹ es una infección del recién nacido caracterizada por ictericia, hepatoesplenomegalia, secreción nasal mucopurulenta, pénfigo palmoplantar, petequias, neumonía alba, laringitis, gastroenteritis, osteocondritis de huesos largos, nariz en silla de montar, dientes de Hutchinson.

8.1.2. Definición de caso de sífilis gestacional

Toda mujer embarazada, puérpera o con aborto reciente con evidencia clínica de úlcera genital o lesiones compatibles con sífilis secundaria y/o prueba treponémica (incluidas pruebas treponémicas rápidas) o no treponémica reactiva con valores de 1:8 diluciones, que no ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación.

8.1.3. Definiciones de caso de sífilis congénita (SC)

Para fines de vigilancia epidemiológica, los criterios recomendados para definir un caso de sífilis congénita son:

- Todo niño, aborto o mortinato cuya madre tiene evidencia clínica de úlcera genital o lesiones compatibles con sífilis secundaria y/o prueba treponémica (incluidas prueba treponémica rápida) o no treponémica reactiva durante la gestación, parto o puerperio, que no haya sido tratada o haya sido tratada inadecuadamente (tratamiento incompleto o con medicamento diferente a la penicilina benzatínica de 2'400.000 UI).

- Todo niño con una o varias manifestaciones clínicas sugestivas de SC al examen físico y/o evidencia radiográfica de SC y/o resultado positivo de una prueba treponémica o no treponémica.

- Todo neonato con títulos de RPR/VDRL cuatro veces mayor que los títulos de la madre o lo que equivale a un cambio en dos diluciones o más de los títulos maternos. Por ejemplo, de 1:4 en la madre a 1:16 en el neonato.

Las manifestaciones clínicas sugestivas de SC son: distrofias, neumopatías, laringitis (llanto ronco y continuado), gastroenteritis, hepatoesplenomegalia, osteocondritis de huesos largos al examen radiológico, rinitis mucopurulenta, pseudoparálisis, ictericia y/o anemia, lesiones mucocutáneas como pápulas, placas infiltradas rojizas en región peribucal, miembros, palmas, plantas, perianales y perigenitales, roséolas, ampollas palmo plantares.

Todo caso diagnosticado como sífilis neonatal se debe remitir a las unidades especializadas para su tratamiento y seguimiento.

59. Fotos N° 12.



8.2. PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA SÍFILIS

Se ofertará la realización de pruebas para sífilis por prueba serológica de VDRL o RPR en los siguientes casos:

- Todo usuario con un diagnóstico sindrómico de ITS.
- Todo usuario con historia de ITS previas.
- Usuario con comportamiento y prácticas sexuales que le exponen a contraer ITS.
- Mujeres gestantes en la **primera consulta prenatal, de preferencia en el primer trimestre** de gestación, se realizará otra prueba en el **tercer trimestre** y finalmente en el momento del **parto o puerperio**.
- Contactos de todas las personas mencionados anteriormente.

Para el alta de toda mujer que se ha atendido por parto o aborto se debe disponer de una prueba reciente de VDRL o RPR.

8.3. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO

Para realizar una prueba de reagina rápida inespecífica **RPR o VDRL, cualitativo**, se extraerán 5 cc de sangre venosa. En aquellas que resulten "**reactivas**", se procederá inmediatamente a realizar las pruebas **cuantitativas**, efectuando diluciones y estableciendo el título. Todos los reportes deben incluir las diluciones expresadas en forma de quebrado o de fracción (ejemplo $\frac{1}{4}$ o 1:4).

Para aquellos resultados reactivos y con títulos menores a 1:8, sobre todo en mujeres embarazadas, se realizará una prueba de detección específica como MHTPA⁶⁰ o FTA ABS, sin que la realización de esta prueba de laboratorio retrase la administración del tratamiento de todos los casos que se obtengan resultados reactivos.

8.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

Las pruebas de detección suelen ser reactivas pasadas dos semanas de la infección. Sin tratamiento, las pruebas serológicas permanecen reactivas durante mucho tiempo, aunque la sensibilidad baja con los años. Con el tratamiento las pruebas se negativizan; sin embargo, algunos usuarios pueden permanecer con títulos bajos (menores a 1:4) por largo tiempo o de por vida.

Para la discriminación de la sífilis latente, temprana y tardía, es necesario contar con una prueba de detección no reactiva, dentro de los dos años previos a la obtención del resultado actual. En caso de no poder obtener esta información, se debe tratar como sífilis latente tardía.

El seguimiento luego del tratamiento debe incluir pruebas serológicas (VDRL o RPR) cada tres meses por un año. Es importante evidenciar una disminución de los títulos de VDRL o RPR cuantitativo de por lo menos dos diluciones menores a la inicial, hasta llegar a su desaparición. En caso de mantenerse títulos, a pesar de tratamiento completo, debe considerarse la posibilidad diagnóstica de sífilis latente tardía o neurosífilis, y se debe valorar también la posibilidad de reinfección.

60. MHTPA: Microhemaglutinación de *treponema pallidum*.



En casos en los que los títulos de inicio de tratamiento sean altos, se puede considerar al paciente como curado con una disminución en dos diluciones que persista en las siguientes dos pruebas de control. El título hasta allí determinado se denomina **huella inmunológica**. Estos últimos títulos se consideran basales y cualquier incremento a partir de este se considera reinfección.

Para el diagnóstico de neurosífilis, se debe efectuar la prueba de VDRL o RPR en líquido cefalorraquídeo. Los controles que amerita el caso deben incluir examen del líquido cefalorraquídeo cada año de por vida.

8.5. TRATAMIENTO

El tratamiento de la sífilis **primaria y latente precoz** es de una sola dosis de **penicilina benzatínica 2.400.000 UI intramuscular**, previa prueba de sensibilidad. En caso de alergia se utilizará doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días o tetraciclina 500 mg cuatro veces al día por 14 días, **excepto en el embarazo**, cuando se administrará penicilina benzatínica 2.400.000 UI intramuscular, previa desensibilización.

En la **sífilis latente tardía** así como en aquella en la que no podamos descartar que se trate de una sífilis temprana, el tratamiento debe ser con penicilina benzatínica 2.400.000 UI intramuscular, **una dosis semanal por tres semanas**. Los regímenes alternativos son los mismos antes señalados para la sífilis primaria por 21 días.

Todo paciente con tratamiento diferente al de penicilina debe ser seguido para búsqueda de recurrencias por al menos cinco años; cada tres meses por un año y luego cada año hasta los cinco años. En caso de presentarse una recurrencia, y luego de descartarse reinfección, se debe considerar desensibilización con penicilina y aplicación del tratamiento con este medicamento.

El tratamiento para sífilis terciaria es con penicilina G sódica (cristalina), intravenosa de 3 a 5 millones UI cada cuatro horas por 14 días.⁶¹ En caso de alergia a la penicilina debe iniciarse el protocolo de desensibilización,⁶² que debe realizarse en unidades con capacidad para resolver las complicaciones y situaciones de emergencia.

En el caso de **mujeres embarazadas** el tratamiento de la sífilis debe iniciarse de inmediato después de obtener el resultado de una prueba de tamizaje reactiva, preferiblemente en el primer nivel de atención, a menos que las condiciones de la mujer requieran una atención de mayor complejidad. Para fines de la prevención de la sífilis congénita se considera adecuado, si el tratamiento se realiza **antes de la semana 34**, o sea, al menos un mes antes del parto. Si el diagnóstico de sífilis se realiza después de la semana 34, el tratamiento se debe realizar con penicilina G sódica (cristalina), intravenosa de 3 a 5 millones UI cada cuatro horas por 14 días,⁶³ en unidades especializadas en prevención de la transmisión materno-infantil.

Se debe hacer prueba para sífilis a todos los contactos sexuales de la embarazada y tratar a todos los contactos positivos o no con el mismo esquema usado para la embarazada. **La reinfección por la pareja no tratada es una de las causas más importantes de la sífilis congénita.**

Todas las personas tratadas deben ser evaluadas con pruebas serológicas cuantitativas con una periodicidad de tres meses por un año. Un aumento de los títulos igual o superior a cuatro veces la dilución inicial constituye indicación de administrar un nuevo tratamiento al considerarse fracaso terapéutico, reinfección o neurosífilis, que además requiere un estudio de líquido cefalorraquídeo (si hay disponibilidad para esta prueba).

61. Guía para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. OMS, 2001, p. 46.

62. Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH y sífilis congénita y manejo de niños y niñas con VIH. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010, p. 38.

63. Guía para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. OMS, 2001, p. 46.



La administración del tratamiento debe ser supervisada y registrarse en la historia clínica. Si no se encuentra evidencia en la historia clínica de su administración, el recién nacido deberá ser considerado un caso de sífilis congénita.

8.6. DESENSIBILIZACIÓN

Los pacientes con prueba positiva a uno de los determinantes de la penicilina pueden ser desensibilizados. Es un proceso relativamente seguro, pero laborioso que puede ser realizado de forma oral o de forma intravenosa; aunque las dos formas de desensibilización no han sido comparadas, la oral parece más segura y más fácil de realizar. La desensibilización se debe realizar en un medio hospitalario, debido a que las reacciones alérgicas, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir y constituyen una urgencia. La desensibilización se puede completar en cuatro horas, después de las cuales se administra la primera dosis de penicilina.

Algunos autores recomiendan mantener dosis diarias bajas (500.000 UI por vía oral) de penicilina hasta completar las tres semanas. La desensibilización debe realizarse bajo supervisión médica, teniendo corticoides y adrenalina a disposición, por si se presentara algún efecto secundario.

Este esquema deberá repetirse antes de cada dosis inyectable semanal.

En caso de no poder utilizar penicilina, no se dispone de alternativas efectivas de tratamiento. Podría utilizarse eritromicina, 500 mg/6 horas durante 14 días (CIII), que puede no ser suficiente para la madre, requiriendo tratamiento con doxiciclina tras el parto con 200 mg/día durante 14 días. El tratamiento con eritromicina de la embarazada es absolutamente ineficaz para tratar al feto, por lo que se administrará penicilina al niño según esquema recomendado más adelante.

Protocolo para la desensibilización oral para pacientes con prueba cutánea positiva

Penicilina V suspensión de dosis (*)	Cantidad (**) (UI/ml)	ml	UI	Dosis acumulada (UI)
1	1.000	0,1	100	100
2	1.000	0,2	200	300
3	1.000	0,4	400	700
4	1.000	0,8	800	1.500
5	1.000	1,6	1.600	3.100
6	1.000	3,2	3.200	6.300
7	1.000	6,4	6.400	12.700
8	10.000	1,2	12.000	24.700
9	10.000	2,4	24.000	48.700
10	10.000	4,8	48.000	96.700
11	80.000	1,0	80.000	176.700
12	80.000	2,0	160.000	336.700
13	80.000	4,0	320.000	656.700
14	80.000	8,0	640.000	1'296.700

Período de observación: 30 minutos antes de la administración parenteral de la penicilina.

Fuente: Wendel GO Jr., Stark BJ., Jamison RB., Melina RD., Sullivan TJ., Penicillin allergy and desensitization in serious infections during pregnancy. N Engl J Med 1985; 312: 1229-32.

(*) El intervalo entre las dosis es de 15 minutos; tiempo transcurrido, 3 horas y 45 minutos; dosis acumulada 1,3 millones de unidades.

(**) La cantidad específica de penicilina se diluye en aproximadamente 30 ml de agua y después se administra oralmente.



Sífilis en el paciente con VIH: en la sífilis temprana y latente precoz, el tratamiento siempre incluirá tres dosis de penicilina, una semanal. En casos de alergia a la penicilina se deberá realizar desensibilización.

Por la importancia del seguimiento, se debe brindar al usuario consejería para apoyo emocional, informar del medicamento utilizado, las dosis usadas y los resultados de laboratorio, así como la posibilidad de quedar con la huella inmunológica y la necesidad de seguimiento, por lo menos por un año.

Todos los casos de sífilis que cuentan con resultado de laboratorio se deben reportar en los formatos de EPI 2, así como la sífilis primaria en el concentrado mensual en los formatos que el Programa Nacional de VIH/Sida e ITS dispone para el efecto.



CAPITULO IX

CONSEJERÍA Y EDUCACIÓN

La consejería y la educación de la persona afectada con una ITS se deben considerar como parte de la consulta, son esenciales para promover la adopción de prácticas sexuales seguras tales como uso correcto del condón y reducción del número de parejas sexuales. Además, ayudan a que las parejas sexuales disminuyan el riesgo de contagio por ITS por el afectado.

9.1. DEFINICIONES

La **educación** es un proceso continuo a través del cual se entrega información al usuario para entender la infección que le aqueja, los mecanismos de prevención y cómo evitar la transmisión.

La **consejería** es un proceso de comunicación cara a cara, para ayudar a los usuarios a **resolver problemas y cambiar actitudes y comportamientos** que puedan poner al usuario en riesgo de adquirir una ITS.

9.2. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO

9.2.1. Objetivo de la educación

Lograr que la persona afectada con una ITS evite la transmisión de la infección a otras personas y, luego de recibir tratamiento adecuado, pueda mantenerse sin infección. El educador debe hacer hincapié en los siguientes mensajes educativos:

- Las ITS se **transmiten** a través de **contacto sexual**.
- Las ITS pueden tener **complicaciones graves** si no son tratadas adecuadamente.
- Entender las **formas de transmisión** de las ITS y por consiguiente las **formas de prevención** de las mismas.
- Las ITS facilitan la transmisión de VIH.
- El **cumplimiento del tratamiento** es necesario para curar la infección.
- Se debe referir a la **pareja al servicio de salud** para que reciba un **diagnóstico y tratamiento**.
- Es importante **no tener relaciones sexuales** hasta que complete el tratamiento.



- Es importante adoptar **prácticas sexuales más seguras**, incluyendo el uso correcto del condón.
- Es importante **regresar a la consulta para evaluar el tratamiento**, darle de alta, o si no existe mejoría del problema referir a un nivel superior.
- En algunas ocasiones, se requiere un apoyo mayor para que la persona pueda responder a los mensajes de la educación sobre las ITS.

9.2.2. Objetivo de la consejería

Ayudar al usuario a identificar situaciones que exponen a la persona a una ITS, resolver los problemas o barreras que impidan cambiar sus actitudes y/o comportamientos para disminuir su riesgo de adquirir una ITS.

El personal capacitado deberá estar alerta para poder orientar sobre:

- **Comportamientos de alto riesgo del usuario.** Es necesario evaluar el riesgo del usuario de forma respetuosa y sin provocar temor.
- Hacer conocer la variedad de **comportamientos sexuales de bajo riesgo** y el uso del condón.
- La necesidad de que la persona afectada por una ITS siga estrictamente el tratamiento recomendado, tomando la dosis recetada, sin dejar de tomar el medicamento cuando los síntomas comienzan a disminuir o desaparecer. Destacar la importancia de **completar el tratamiento** para que la infección se cure totalmente.
- La **responsabilidad del usuario sobre la transmisión** de las ITS. Orientar sobre la suspensión de las relaciones sexuales hasta completar el tratamiento.
- La **referencia** de las parejas sexuales al servicio de salud para que reciban diagnóstico y tratamiento.
- Las ITS que no se tratan a tiempo pueden tener complicaciones y comprometer su vida y la posibilidad de infectar al recién nacido en el caso de embarazadas.
- Tanto a la mujer como al varón, se les debe informar la necesidad e importancia del control prenatal y de descartar sífilis y VIH al inicio y en el transcurso del embarazo.
- En los casos de sífilis, se deberán explicar las particularidades de esta infección, la necesidad de controles para poder dar de alta, el significado de la huella inmunológica y la importancia de tratar a todos los contactos sexuales, tengan resultados positivos o no.

Durante la sesión de consejería, el consejero debe:

- Escuchar atentamente al usuario.
- Respetar la dignidad del usuario.
- Aceptar las diferentes expresiones de la sexualidad.
- Enfatizar que la consejería es confidencial.
- Conversar sobre sus necesidades de apoyo.
- Brindar la información adecuada a sus necesidades.
- Ayudar al usuario a realizar una valoración de su riesgo de infectarse con una ITS.
- Realizar demostración y ofrecer mayor entrenamiento en el uso correcto del condón y cómo discutir el uso con su pareja.
- Ayudar a reconocer las dificultades con relación al uso del condón con sus parejas y encontrar estrategias que faciliten romper sus barreras y prejuicios.
- Escuchar y tratar de entender los sentimientos y/o razones que exponen el usuario, como dificultades en tomar decisiones u acciones que contribuyan a disminuir su riesgo de infectarse con una ITS.
- Elaborar conjuntamente un plan de prevención, acorde a las posibilidades del usuario para cumplir el mismo, y protegerse de las ITS incluyendo el VIH.
- Ofrecer apoyo a los esfuerzos del usuario para tomar decisiones y resolver problemas.



CUADRO N° 3 EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA PRÁCTICA SEXUAL

RIESGO	PRÁCTICA SEXUAL
RIESGO ALTO	Sexo anal o vaginal receptivo sin condón Sexo anal o vaginal penetrativo sin condón
RIESGO MEDIO	Sexo anal o vaginal receptivo con condón; sexo anal o vaginal penetrativo con condón Sexo oral sin condón; sexo oral sin barrera de látex (barrera de protección); sexo interfemoral (entre los muslos) Introducción de un dedo o mano en la vagina o el ano; compartir juguetes sexuales (pene de goma, vibradores, etc.), sin condón y sin desinfectarlos o limpiarlos
RIESGO BAJO	Sexo oral al varón sin colocar la cabeza del pene (glande) en la boca; masturbar a la pareja evitando el contacto con semen o fluido vaginal; dar o recibir sexo oral con barrera de látex (barrera de protección); besos profundos (beso francés); compartir juguetes sexuales con condón, limpios o desinfectados; frotación cuerpo a cuerpo.
SIN RIESGO	Abstinencia sexual, abrazos, masajes, masturbación, fantasías, besos secos, no compartir juguetes sexuales, baño caliente de tina en pareja, ducharse juntos, sauna.

9.3. CONTACTOS

Se define como **contacto** a todas las **personas** con las que el usuario ha tenido **relaciones sexuales**:

- En los últimos **60 días** para flujo uretral, cervicitis, dolor abdominal bajo, tricomoniasis, gonorrea e infección por clamidia.
- En los últimos **90 días** para úlcera genital, bubón inguinal.
- En los últimos **12 meses** para sífilis latente.

En las ITS la búsqueda activa de casos está sujeta al consentimiento del usuario, generalmente, son los usuarios quienes refieren a sus parejas.

Los principios de un buen manejo de los contactos se basan en:

- Estar capacitado.
- Guardar la confidencialidad.
- Estar informado y ofrecer una red de servicios de diagnóstico y tratamiento de ITS disponibles para todas las parejas sexuales de los casos índices.
- Evitar la discriminación y estigmatización a los usuarios.
- Es importante motivar el **regreso a la consulta para evaluar el tratamiento**, darle de alta, o si no existe mejoría del problema referir a un nivel superior.



9.4. CONDOMES EN ITS

El mercadeo social de condones constituye una estrategia esencial dentro de los programas de prevención de infecciones de transmisión sexual.

El éxito del mercadeo social del condón depende de la realización de las siguientes acciones:

- Combinar el incremento de la accesibilidad con la promoción de su uso.
- Precios adecuados y venta en lugares convenientes.
- Incluir la venta en lugares no tradicionales como lugares de recreación, campismo, hoteles, bares, etc.
- Contribuir a disminuir tabúes sociales por medio de la publicidad.
- Debe estar acompañado de programas de información sobre la efectividad de su uso en la prevención de ITS.

La promoción de condones incluye:

- Consejería sobre el uso de condones
- Demostración sobre su uso correcto
- Entrega gratuita o bajo costo

No obstante, existen restricciones para el uso correcto y consistente de condones, que pueden depender del individuo pero también de los servicios de salud.

En el individuo:

- Mala opinión sobre los condones
- Falta de confiabilidad en el condón
- Poca familiaridad con el tema, lo que genera vergüenza
- Desconfianza entre los miembros de la pareja si se plantea su uso
- Dificultades individuales para una adecuada negociación del uso de condones
- Interferencia con el placer sexual
- Difícil acceso

En las unidades de salud:

- Insuficiente capacitación del personal
- Énfasis excesivo en los aspectos terapéuticos
- Poco énfasis en la prevención y en cambios de comportamiento
- Falta de privacidad
- Actitudes prejuiciadas del personal

El manejo efectivo de casos de ITS incluye entre las 4C la promoción del uso de condones. Para mejorar la promoción del uso de condones en servicios de salud y en otros sectores, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Existe suficiente evidencia científica que corrobora la disminución de la transmisión de las ITS cuando se utiliza de forma **correcta y consistente el condón**, aunque no se llega a eliminar el riesgo por completo. Un estudio de la Food Drug Administración (FDA) mostró que **reduce diez mil veces la transferencia de fluidos**.



Se deben también considerar los posibles fracasos en el uso del condón debido a la rotura del mismo. Entre las causas de rotura se reportan las siguientes:

- Defectos en la fabricación
- Deficientes condiciones de almacenaje (calor, humedad)
- Defectos en el uso

Entre los posibles errores en el uso del condón se encuentran:

- No usar el condón en todas las relaciones sexuales incluidas las ocasionales.
- Mantener penetraciones previas al uso de condón.
- Realizar maniobras para verificar la calidad del condón (inflar, soplar, desenrollarlo).
- No seguir los pasos para colocarlo correctamente, que permite el deslizamiento accidental del condón.
- Usar lubricante con base oleosa (vaselina, cremas cosméticas o vaginales).
- Usar el mismo condón más de una vez.
- Usar el mismo condón para penetraciones anales y luego vaginales.
- Ingerir alcohol antes de mantener relaciones sexuales, lo que facilita el colocarlo inadecuadamente o no usarlo.

9.4.1. Estrategias para el uso correcto del condón

El condón es una estrategia fundamental para atender integralmente las ITS, por ello, es importante que el personal de salud se capacite en realizar demostraciones de uso correcto de condón y promueva el uso del mismo.

El personal de salud debe incluir la demostración del uso del condón, tomando en consideración lo siguiente:

- Brindar la suficiente confianza al usuario en el **uso de un solo condón** de buena calidad que sea de **látex natural**, en cada relación sexual.
- Asegurarse de que el usuario distinga la **calidad del condón**, revisando fechas de fabricación, caducidad. Solo usar hasta la fecha de expiración.
- Indicar que lo **use antes de cualquier penetración** y lo coloque siempre que el pene se halle erecto.
- Indicar que se debe evitar que queden **burbujas de aire**, para ello se sujeta la dilatación del condón con los dedos índice y pulgar.
- Indicar que se deje **suficiente espacio** libre para el juego sexual.
- Se debe indicar que se **deslice el condón hasta la base del pene**, para evitar que se quede dentro de la vagina.
- Si necesita lubricante, recomendar el uso de **lubricantes solubles en agua** (K-y, Bioglides, Surgilubri), especialmente en las relaciones anales donde hay más riesgo de rotura.
- Recomendar que retire el pene y el condón juntos, tan pronto como se ha terminado la relación sexual, para evitar que se quede en vagina.
- Es importante revisar el condón para estar seguro de que no se ha roto. Eliminarlo de modo seguro (enrollarlo) para evitar que los niños que minan basura los inflen; envolverlo en papel higiénico y desecharlo en la basura, no en el inodoro porque se tapan las cañerías.
- Insistir que el condón protege cuando su uso es **correcto, constante y consistente**, es decir, en todas las relaciones sexuales.

Recientemente se ha iniciado un proceso de introducción del condón femenino. Ante la negativa a usar el condón masculino por parte de muchos varones, y la dificultad de negociar el uso del



mismo por las mujeres, dificultad que aumenta cuando se trata de la pareja habitual, el condón femenino aporta una alternativa de mayor autonomía para la mujer. Tiene algunas dificultades que se relacionan con la mayor necesidad de demostración y mayor necesidad de oportunidades de practicar. Algunas recomendaciones para el uso del condón femenino:

- Fijarse en la fecha de caducidad de los condones femeninos, si está vencida se debe descartar.
- No utilizar tijeras o cuchillos u otros objetos punzantes para abrir el empaque.
- Las mejores posiciones para colocarlo son: de pie con una pierna en una silla, sentada y con las piernas recogidas (en cuclillas), o sentada en una silla y con las piernas abiertas.
- Distribuya la lubricación rozando el condón femenino mientras todavía esté en el paquete.
- El condón tiene dos aros. Utilice el anillo interior apretado para empujar el condón femenino hacia dentro de la vagina. Después inserte el dedo índice o el dedo medio en el condón y empuje el anillo interior hacia dentro de la vagina hasta el fondo.
- Cerca de 2,5 cm de la funda, incluyendo el anillo exterior, se mantendrán fuera del cuerpo. Una vez que entre el pene en la vagina, esos 2,5 cm se acomodarán en el canal vaginal y solo el anillo exterior se quedará fuera. Esto protegerá los genitales externos.
- Para la penetración, sostenga el anillo exterior del condón femenino con una o dos manos y, si está usted cómoda, oriente el pene hacia dentro del condón.
- Se puede colocar con anticipación a la relación sexual.
- Para quitar el condón femenino, agarre el anillo exterior, gire el condón femenino para que no salga el líquido y retírelo suavemente.



CAPÍTULO X

OTRAS ITS FRECUENTES

ENFERMEDAD	ASPECTO	DISTRIBUCIÓN	TRATAMIENTO	OTRAS OBSERVACIONES
Micosis superficial	Lesiones rojizas, bordes irregulares, a menudo con escamas	Línea media del escroto, glúteos, cara interna de los muslos	Miconazol o clotrimazol, griseofluvina de 15 a 20 días Medidas higiénicas, evitar humedad	Lesiones en áreas húmedas, calientes y cubiertas.
Escabiosis ⁶⁴	Áreas eritematosas y escoriadas, con pápulas, pústulas y surcos	Espacios interdigitales, genitales externos, muslos, abdomen y glúteos	Hexacloruro de gama benceno o benzoato de bencilo	Lavar sábanas y ropa de cama; tratar contactos sexuales y familiares.
Pediculosis pubis	Liendres sobre el vello púbico, piel enrojecida e irritada	Vello púbico. Cejas, axilas, pestañas.	Benzoato de bencilo o hexacloruro de gama benceno	Iguals cuidados que en la escabiosis.
Molusco contagioso ⁶⁵	Pápulas umbilicadas blancas, perladas, de superficie lisa	Cualquier zona genital. Pueden hallarse en zonas no genitales	Con diagnóstico confirmado. Hacer raspado de dos a cuatro lesiones por vez y aplicar alcohol yodado o referir al especialista	Suelen sobreinfectarse cuando hay manipulación. Examinar contactos sexuales. Investigar VIH.

64. Foto N° 40.

65. Foto N° 41.



CAPÍTULO XI

ATLAS DE ITS



FOTO N° 1.
CHANCRO PRIMARIO SIFILÍTICO

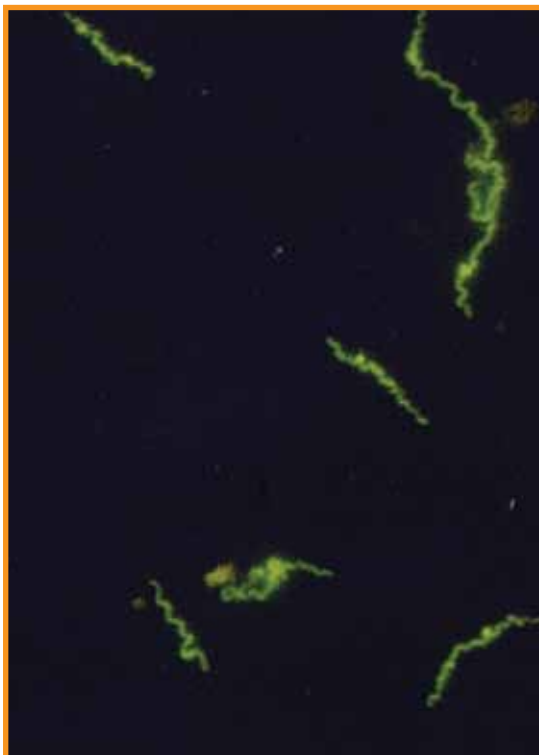


FOTO N° 2.
CHANCRO PRIMARIO SIFILÍTICO





FOTO N° 3.
SÍFILIS PRIMARIA EN LABIOS MAYORES



FOTO N° 4.
SÍFILIS PRIMARIA



FOTO N° 5.
SÍFILIS SECUNDARIA:
ROSÉOLA SÍFILITICA



FOTO N° 6.
SÍFILIS SECUNDARIA





FOTO N° 7.
SÍFILIS SECUNDARIA:
CONDILOMA PLANO



V - 28 - M - UL - STO.DGO. 5to. G - ALBAÑIL
CS: T.S. EV: 2 MESES
SÍFILIS SECUNDARIA

FOTO N° 8.
SÍFILIS SECUNDARIA:
CONDILOMA PLANO



FOTO N° 9.
SÍFILIS SECUNDARIA



FOTO N° 10.
SÍFILIS SECUNDARIA:
ROSÉOLA SIFILÍTICA





FOTO N° 11.
SÍFILIS TERCIARIA:
GOMA SIFILÍTICO



FOTO N° 12.
DIENTES DE HITCHUNSON



FOTO N° 13.
HERPES



FOTO N° 14.
HERPES II





FOTO N° 15.
HERPES II



FOTO N° 16.
HERPES II

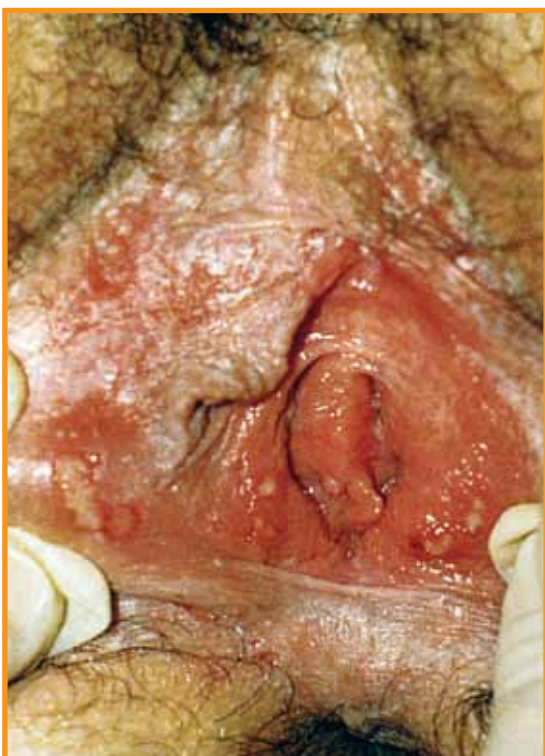


FOTO N° 17.
HERPES II



FOTO N° 18.
GONORREA



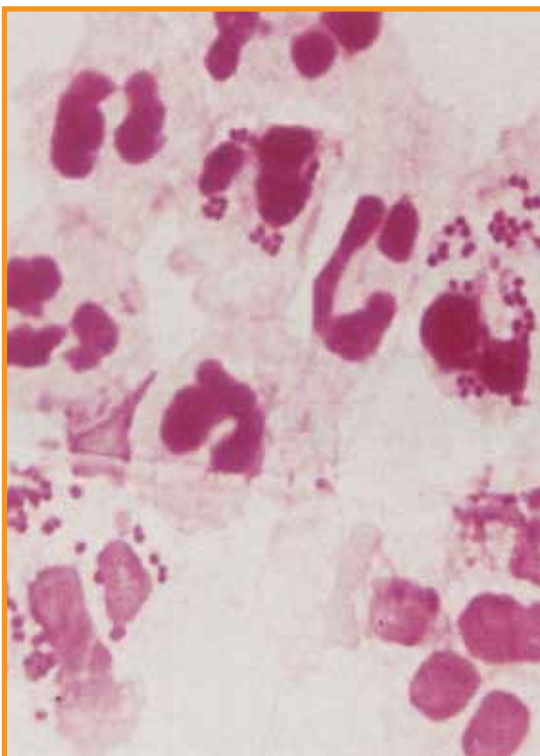


FOTO N° 19.
COCOS EN PAREJA



FOTO N° 20.
GONORREA



FOTO N° 21.
GONORREA



FOTO N° 22.
GONORREA EN CÉRVIX





FOTO N° 23.
GONORREA:
BARTOLINITIS/GONORREA



FOTO N° 24.
CONJUNTIVITIS POR GONORREA



FOTO N° 25.
FOLICULITIS POR GONORREA



FOTO N° 26.
CLAMIDIASIS





FOTO N° 27.
CLAMIDIASIS EN CERVIX UTERINO



FOTO N° 28.
CANDIDIASIS



FOTO N° 29.
TRICOMONIASIS



FOTO N° 30.
VAGINOSIS BACTERIANA:
GARDNERELLA



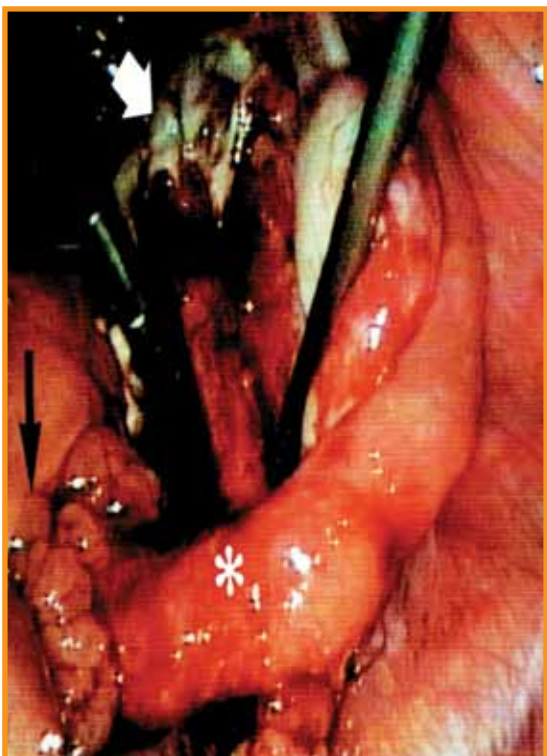


FOTO N° 31.
SALPINGUITIS



FOTO N° 32.
SALPINGUITIS BILATERAL



FOTO N° 33.
EDEMA DE ESCROTO



FOTO N° 34.
BUBÓN INGUINAL





FOTO N° 35.
BUBÓN INGUINAL BILATERAL



FOTO N° 36.
CONJUNTIVITIS NEONATAL



FOTO N° 37.
CONDILOMA POR HPV



FOTO N° 38.
CONDILOMA POR HPV





FOTO N° 39.
HEPATITIS



FOTO N° 40.
ESCABIOSIS CON SOBREINFECCIÓN



FOTO N° 41.
MOLUSCO CONTAGIOSO





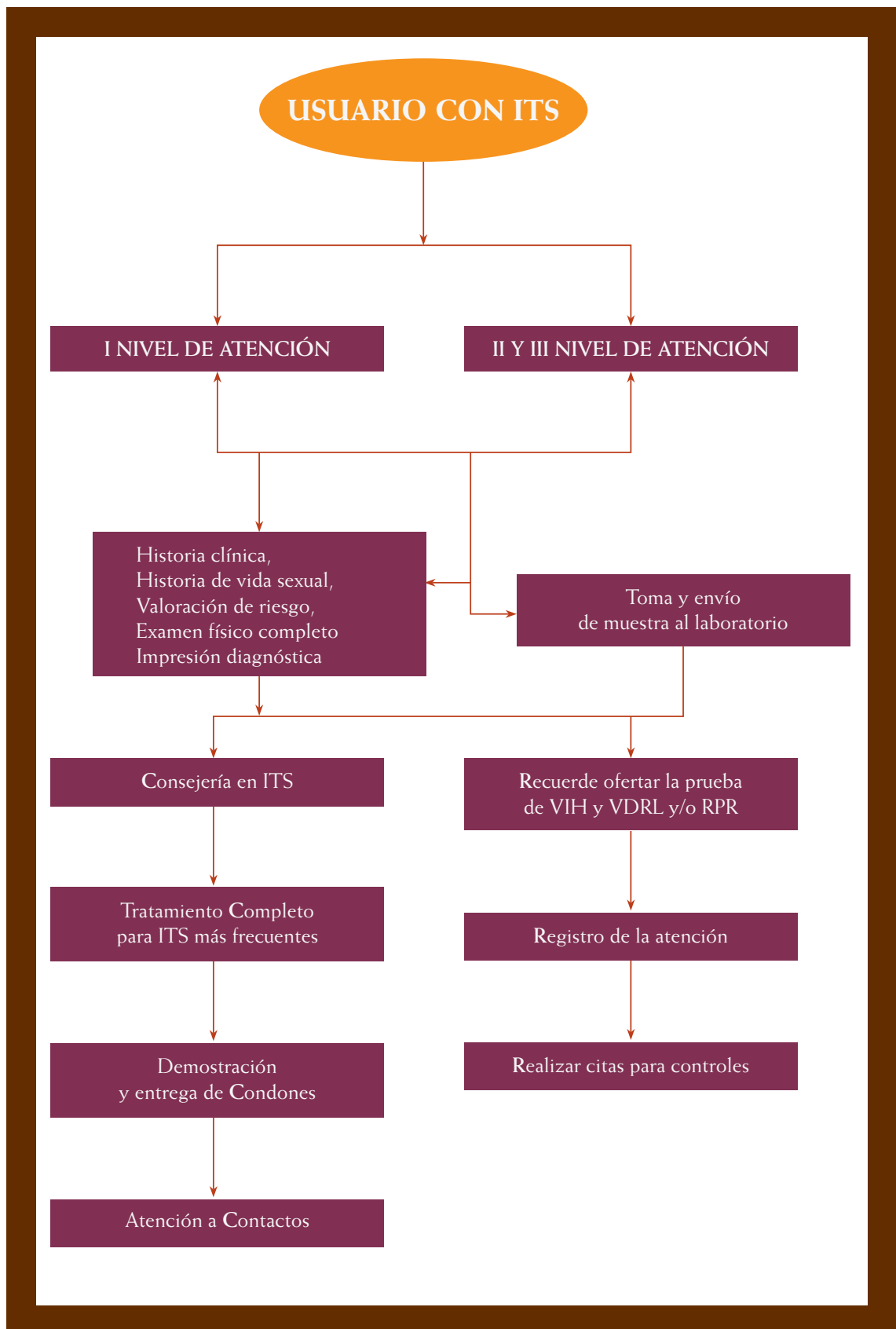
ANEXO 1.
CLASIFICACIÓN DE LAS ITS

Resumen de signos y síntomas de los principales síndromes y su etiología

SÍNDROME	SÍNTOMAS	SIGNOS	PATOLOGÍA MAS COMÚN
Secreción vaginal	Picazón vaginal (prurito) Dolor al orinar (disuria) Dolor durante el acto sexual (dispareunia)	Secreción vaginal	VAGINITIS • Tricomoniasis • Candidiasis • Vaginosis bacteriana CERVICITIS • Gonorrea • Clamidiasis
Secreción uretral	Dolor al orinar Necesidad de orinar frecuentemente	Secreción por la uretra	• Gonorrea • Clamidiasis
Úlcera genital	Llagas en la región genital	Úlceras genitales Lesiones vesiculares	• Sífilis • Chancroide o chancro blando • Herpes genital • Linfogranuloma venéreo
Dolor abdominal bajo	Dolor abdominal bajo Dolor durante el acto sexual	Dolor abdominal bajo al palpar Flujo vaginal Temperatura más de 38° C.	• Gonorrea • Clamidia • Anaerobios
Edema de escroto	Hinchazón y dolor del escroto	Edema del escroto	• Gonorrea • Clamidiasis
Bubón inguinal	Hinchazón dolorosa de la ingle	Ganglios linfáticos inguinales hinchados Abscesos fluctuantes Úlceras	• Linfogranuloma venéreo • Chancroide o chancro blando
Conjuntivitis neonatal	Neonato (menor de un mes) con ojos hinchados y/o enrojecidos	Párpados hinchados con secreción purulenta	• Gonorrea • Clamidiasis



ANEXO 2.
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DE LAS ITS



BIBLIOGRAFÍA

1. CDC. *Directrices para el tratamiento de las ITS*. MMWR 04/08/ 2006 - 55 (RR-11), 1-94.
2. CDC. *Directrices para os tratamentos das doenças sexualmente transmissíveis*. MMWR 04/08/06.
3. CDC. *Tratamiento supresivo para herpes genital recurrente*. MMWR 04/08/06 (RR-11), 94.
4. *Constitución de la República del Ecuador*. Ecuador: 2008.
5. *Controle das doenças sexualmente transmissíveis*. Brasil: Ministério da Saúde Brasil; 2006, p. 45.
6. Ejemplos de Programas, Reproductive Health Outlook. www.iesmer.org/RHO/html/rtis.
7. Gómez, Corolina. "Infecciones de transmisión sexual. puerta de entrada para el sida". En *La Jornada*, 5 de enero del 2005.
8. *Guía de manejo de las infecciones de transmisión sexual*. Argentina: Programa Nacional de lucha contra los retrovirus del humano, sida y ETS; 2007.
9. Herrera, María Teresa y Col. "Tamizaje serológico y con PCR para determinar la prevalencia de chlamydia trachomatis en pacientes con vaginosis y vaginitis inespecífica que asisten a hospitales de la Secretaría de Salud de Bogotá". En *Nova*. volumen 3, junio 2005, p. 1-120.
10. Heymann, David. *El control de las enfermedades transmisibles*. Washington DC: OPS/OMS; 2005.
11. Hogben, Matheu. *Revisión y comentarios sobre el tratamiento suministrado por profesional, paciente a su pareja en ITS en Estados Unidos*. SucSalud. www.siicsalud.com/dato/dat044
12. *Informe de la evaluación de programas nacionales de ITS de Latinoamérica y el Caribe*. Lima, Perú: OPS; marzo 2008.
13. M. Romoren y Col. "Tricomoniasis y vaginosis bacteriana en el embarazo". En *Boletín de la Organización Mundial de la Salud*, volumen 85, abril 2007.
14. MSP. *Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH y sífilis congénita y manejo de niños y niñas con VIH*. Ecuador: Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 2010.
15. MSPAS. *Guía de atención de infecciones de transmisión sexual*. El Salvador: MSPAS, Programa Nacional de ITS - VIH/Sida, 2º edición; junio, 2006.
16. *Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo: una guía para la práctica básica*. Ginebra, Suiza: OPS/OMS; 2005.
17. *Infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida*. Population Council, 2004 -04-13.
18. *Infecciones de tracto reproductivo: Definiciones de morbilidad ginecológica*. Population Council, 2006.
19. Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Sida, *Normas de manejo y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual*, norma técnica N° 46. Santiago de Chile: 2000.
20. *Módulos de capacitación para manejo sintomático de las infecciones de transmisión sexual*. 2ª edición. Organización Mundial para la Salud; 2008.
21. Nagot, Nicolas y Col. "Tratamiento del virus del herpes simplex tipo 2 y eliminación del VIH". En *The New England Journal of Medicine*, 8, February, 2007.
22. *Guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual*. Ginebra, Suiza: OMS; 2005.
23. *Pautas para la vigilancia de infecciones de transmisión sexual*. ONUSIDA/OMS/OPS. 1999.
24. Peredo, Carolina. *Infecciones de transmisión sexual en adolescentes*. Medwave, año VII, N° 2, 2007.
25. Rojas, María Elena y Col. *Manual de manejo sintomático de las ITS*. Ecuador: Ministerio de Salud Pública del Ecuador; 2007.
26. Rius, Cristina y Col. *Epidemiología de la infección por el VIH/Sida y su relación con otras infecciones de transmisión sexual, Perspectivas de futuro*. En *Enfermedades infecciosas y microbiología clínica*, volumen 22, N° 7, 2004, p. 419-429.
27. "Sida e infecciones de transmisión sexual en las Américas". En *Revista Panamericana de la Salud*, Vol. 6, N° 3, sept. 1999.
28. Turnes, Antonio. *La sífilis en la medicina, una aproximación a su historia*. 2007.
29. Valderrama, Julia y Col. "Sífilis materna y sífilis congénita en América latina: Un problema grave de solución sencilla". En *PAHO Revista Journal*, volumen 16 (3), septiembre 2004, p. 211-217.
30. Vélez, Hernán. *Manual de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual*. Medellín, Colombia: Corporación de para investigaciones biológicas; 2005.





